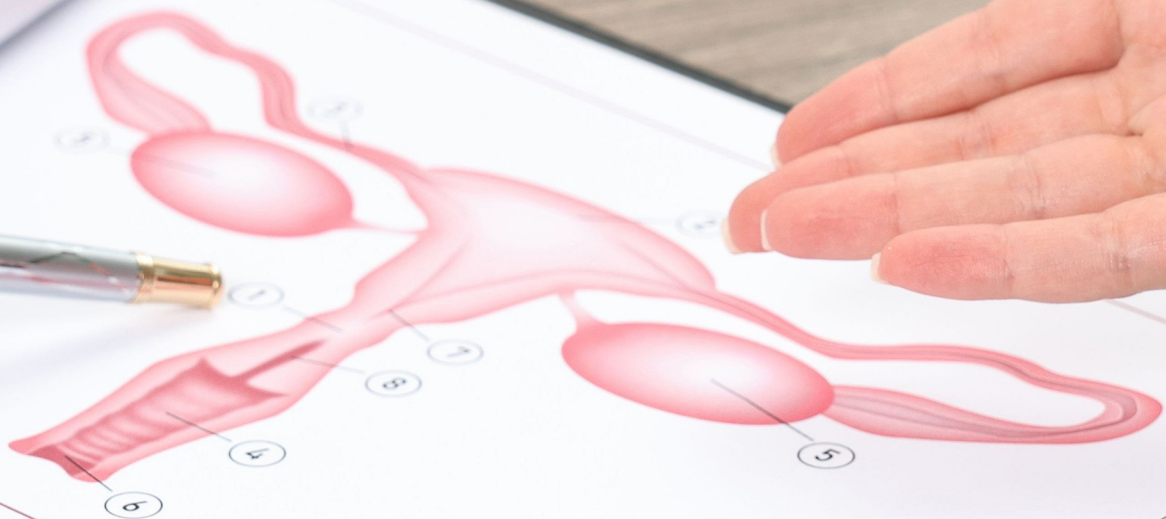


DEDIKASI

Strategi Inovatif Deteksi Dini Kanker Serviks pada Wanita Usia Subur

Irna Nursanti • Kartini K Rahantoknam • Dhea Natasha
Diana Irawati • Dewi Anggraini • Idriani
Heri Rosyati

Editor: Nilawati Uly



DEDIKASI:

Strategi Inovatif

Deteksi Dini Kanker Serviks

pada Wanita Usia Subur

Dr. Irna Nursanti, M.Kep., Sp.Mat.

Ns. Kartini K Rahantoknam, M.Kep.

Dhea Natasha, S.Kep., Ns., M.S., PhD.

Diana Irawati, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.KMB.

Ns. Dewi Anggraini, S.Kep., M.S.

Ns. Idriani, M.Kep., Sp.Mat.

Heri Rosyati, SSiT., M.KM.

Editor: Prof. Dr. Nilawati Uly, S.Si., Apt., M.Kes.



DEDIKASI:**Strategi Inovatif Deteksi Dini Kanker Serviks pada Wanita Usia Subur****Penulis:**

Dr. Irna Nursanti, M.Kep., Sp.Mat.
Ns. Kartini K Rahantoknam, M.Kep.
Dhea Natasha, S.Kep., Ns., M.S., PhD.
Diana Irawati, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.KMB.
Ns. Dewi Anggraini, S.Kep., M.S.
Ns. Idriani., M.Kep., Sp.Mat.
Heri Rosyati, SSiT., M.KM.

Editor:

Prof. Dr. Nilawati Uly, S.Si., Apt., M.Kes.

ISBN: 978-623-10-9814-6

Desain Sampul : Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak : Achmad Faisal

Cetakan Pertama: Mei, 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Jakarta Barat

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ajar ini, yang berjudul *DEDIKASI: Strategi Inovatif Deteksi Dini Kanker Serviks pada Wanita Usia Subur*, dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai respon terhadap tingginya angka kejadian kanker serviks di Indonesia serta pentingnya peran tenaga keperawatan dalam edukasi kesehatan reproduksi perempuan.

Strategi DEDIKASI disusun dengan mengedepankan pendekatan berbasis komunitas, disertai media e-booklet sederhana yang dapat digunakan oleh perawat, mahasiswa keperawatan, kader kesehatan, maupun tenaga edukator lainnya. Melalui panduan ini, diharapkan pembaca tidak hanya memahami konsep teoretis terkait deteksi dini kanker serviks, tetapi juga mampu mengimplementasikannya secara konkret di lapangan dengan pendekatan yang humanis, empatik, dan partisipatif.

Buku ajar ini disusun dengan mengacu pada Model Promosi Kesehatan Nola J. Pender, serta didukung oleh pengalaman implementasi edukasi di berbagai komunitas perempuan usia subur. Konten buku disajikan secara bertahap, mulai dari teori dasar, strategi implementasi, simulasi praktik, hingga refleksi dan kolaborasi lintas profesi. Seluruh isi ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami oleh mahasiswa diploma, sarjana keperawatan, serta perawat praktisi di lapangan.

Kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan dan ruang untuk pengembangan lebih lanjut. Oleh karena itu, masukan dan kritik konstruktif dari para pembaca, pendidik, dan praktisi sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang.

Akhir kata, kami berharap buku ajar ini dapat menjadi kontribusi nyata dalam mendukung upaya pencegahan kanker serviks di Indonesia dan memperkuat peran strategis perawat dalam edukasi kesehatan perempuan. Semoga buku ini memberikan manfaat dan menjadi inspirasi dalam setiap langkah edukatif dan promotif yang dilakukan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 KONSEP DASAR KANKER SERVIKS	1
Pengertian dan Etiologi Kanker Serviks.....	1
Faktor Risiko dan Epidemiologi	3
Gejala Klinis dan Stadium Kanker Serviks	5
Dampak Kanker Serviks terhadap Kesehatan Wanita.....	8
BAB 2 WANITA USIA SUBUR (WUS).....	11
Definisi dan Karakteristik Wanita Usia Subur.....	11
Kesehatan Reproduksi pada WUS	14
Masalah Kesehatan yang Sering Terjadi pada WUS	16
Perilaku Pencegahan Kanker Serviks pada Wanita Usia Subur	19
Dukungan Sosial dan Keluarga.....	20
Tantangan Deteksi Dini Kanker Serviks di Kalangan WUS.....	21
Peran Tenaga Kesehatan dalam Edukasi WUS tentang Kanker Serviks.....	22
BAB 3 PENTINGNYA DETEKSI DINI KANKER SERVIKS.....	28
Pengertian Deteksi Dini Kanker Serviks.....	28
Keuntungan dan Pentingnya Deteksi Dini	30
Jenis dan Metode Deteksi Dini Kanker Serviks.....	32
Hambatan dalam Pelaksanaan Deteksi Dini	35
Strategi Mengatasi Hambatan Deteksi Dini	37
BAB 4 PERAN PERAWAT DALAM DETEKSI DINI KANKER SERVIKS	39
Peran Perawat sebagai Edukator	39
Peran Perawat sebagai Advokat Kesehatan.....	40
Peran Perawat dalam Skrining Kanker Serviks	42
Kompetensi Perawat dalam Deteksi Dini Kanker Serviks	43

BAB 5 MODEL PROMOSI KESEHATAN NOLA J. PENDER	46
Biografi Singkat Nola J. Pender	46
Komponen Utama Model Promosi Kesehatan Pender	47
Implementasi Teori Pender dalam Keperawatan	49
Model Pender dalam Konteks Deteksi Dini Kanker Serviks.....	50
 BAB 6 MENGENAL STRATEGI “DEDIKASI”	52
Filosofi dan Makna DEDIKASI.....	52
Prinsip Kerja dan Tujuan Strategi DEDIKASI	54
Komponen Utama DEDIKASI dalam e-Booklet	54
Alur Implementasi Strategi DEDIKASI.....	56
 BAB 7 IMPLEMENTASI STRATEGI “DEDIKASI” BERBASIS E-BOOK	61
Pengembangan Media e-Booklet untuk Deteksi Dini	61
Isi dan Konten e-Booklet Strategi DEDIKASI	63
Langkah-langkah Penggunaan e-Booklet dalam Praktik Keperawatan	65
Evaluasi Efektivitas Penggunaan e-Booklet.....	66
 BAB 8 STUDI KASUS DAN SIMULASI PRAKTIK.....	69
Studi Kasus Implementasi Strategi DEDIKASI.....	69
Simulasi Praktik Deteksi Dini Kanker Serviks dengan Strategi DEDIKASI.....	71
Evaluasi dan Pembelajaran dari Simulasi Strategi DEDIKASI.....	73
 BAB 9 TANTANGAN DAN SOLUSI DALAM IMPLEMENTASI STRATEGI “DEDIKASI”	75
Hambatan Umum dalam Implementasi di Lapangan	75
Solusi Praktis Menghadapi Tantangan Implementasi.....	77
Kolaborasi Antarprofesi dalam Mendukung Implementasi DEDIKASI	79
Strategi Optimalisasi dan Keberlanjutan Program.....	81
 Daftar Pustaka	83

BAB 1

KONSEP DASAR KANKER SERVIKS

Pengertian dan Etiologi Kanker Serviks

Kanker serviks atau kanker leher rahim merupakan keganasan yang terjadi pada area serviks, yaitu bagian terendah dari rahim yang berhubungan langsung dengan vagina. Kanker ini disebabkan oleh pertumbuhan sel-sel abnormal yang bersifat ganas pada lapisan epitel serviks, yang berpotensi menyebar ke jaringan di sekitarnya atau organ lain dalam tubuh (World Health Organization [WHO], 2022). Pada tahap awal, kanker serviks seringkali tidak menimbulkan gejala yang khas sehingga sulit dideteksi tanpa adanya pemeriksaan khusus. Apabila kanker serviks dideteksi sejak dini melalui pemeriksaan rutin seperti Pap smear atau skrining HPV-DNA, angka kesembuhan dan harapan hidup penderita akan meningkat secara signifikan (*American Cancer Society*, 2023).

Penyebab utama kanker serviks adalah infeksi virus Human Papillomavirus (HPV) tipe risiko tinggi yang bersifat onkogenik, khususnya HPV tipe 16 dan 18. Virus ini menyebar melalui kontak seksual dan mampu mengintegrasikan materi genetiknya ke dalam DNA sel-sel epitel serviks sehingga menyebabkan transformasi sel normal menjadi abnormal (Bruni et al., 2019). Meski infeksi HPV sangat umum terjadi pada wanita usia reproduktif, sebagian besar infeksi akan hilang dengan sendirinya karena sistem imun yang efektif; namun, infeksi yang persisten dapat berkembang menjadi lesi prakanker yang berpotensi menjadi kanker serviks dalam beberapa tahun kemudian (WHO, 2022). Risiko perkembangan infeksi menjadi kanker meningkat apabila ada faktor pendukung lainnya, seperti kebiasaan merokok, defisiensi imun, penggunaan kontrasepsi oral jangka panjang, dan perilaku seksual yang tidak aman (*American Cancer Society*, 2023).

Faktor etiologi tambahan yang berperan dalam kanker serviks mencakup aspek gaya hidup dan perilaku seksual, termasuk usia dini saat pertama kali melakukan hubungan seksual, memiliki banyak pasangan seksual, serta riwayat infeksi menular seksual lain seperti klamidia atau herpes genital (*Centers for Disease Control and Prevention* [CDC], 2021). Selain itu, aspek genetik dan imunologis individu juga mempengaruhi kerentanan terhadap perkembangan kanker ini (CDC, 2021). Pemahaman yang menyeluruh mengenai etiologi kanker serviks sangat penting bagi tenaga kesehatan, khususnya perawat, agar dapat memberikan edukasi dan intervensi pencegahan yang tepat kepada masyarakat, terutama wanita usia subur (Bruni et al., 2019).

Faktor Risiko dan Epidemiologi

Kanker serviks merupakan salah satu jenis kanker yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor risiko yang bersifat kompleks dan saling berkaitan. Faktor utama yang telah terbukti secara ilmiah adalah infeksi Human Papillomavirus (HPV), khususnya tipe 16 dan 18 yang bersifat onkogenik dan bertanggung jawab atas lebih dari 70% kasus kanker serviks di seluruh dunia (World Health Organization [WHO], 2022). Infeksi HPV menyebar terutama melalui kontak seksual dan sering kali terjadi tanpa gejala, sehingga banyak wanita tidak menyadari telah terinfeksi. Meski sebagian besar infeksi HPV akan hilang secara spontan oleh sistem imun, infeksi yang persisten berisiko berkembang menjadi lesi prakanker dan akhirnya kanker serviks (*Centers for Disease Control and Prevention* [CDC], 2021).

Perilaku seksual yang berisiko menjadi faktor pendukung yang memperbesar kemungkinan terjadinya infeksi HPV. Memiliki banyak pasangan seksual atau memiliki pasangan dengan riwayat perilaku seksual berisiko diketahui berkorelasi positif dengan peningkatan kejadian kanker serviks (*American Cancer Society*, 2023). Selain itu, pasangan pria yang tidak disunat dapat menjadi sumber transmisi karena adanya smegma—sekresi di bawah kulup penis—yang dapat menjadi tempat berkembangnya mikroorganisme patogen, termasuk HPV (Rizk et al., 2017). Faktor ini turut memperkuat pentingnya edukasi seksual dan perilaku hidup bersih sebagai bagian dari pencegahan primer.

Aktivitas seksual yang dimulai pada usia muda juga merupakan faktor risiko signifikan. Serviks remaja yang masih mengalami perkembangan seluler lebih rentan terhadap infeksi virus. Penelitian menyebutkan bahwa wanita yang memulai hubungan seksual sebelum usia 18 tahun memiliki risiko hampir tiga kali lipat lebih tinggi mengalami kanker serviks dibandingkan dengan mereka yang memulai pada usia lebih matang (Tessema et al., 2023). Risiko ini meningkat

ketika dikombinasikan dengan tidak adanya penggunaan proteksi, seperti kondom, dan kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi.

Tingkat paritas atau jumlah kelahiran juga dikaitkan dengan kanker serviks. Wanita yang pernah melahirkan lebih dari lima kali disebut memiliki risiko lebih tinggi terkena kanker serviks dibandingkan dengan wanita dengan paritas rendah. Hal ini dapat dijelaskan oleh trauma serviks berulang selama proses persalinan dan perubahan hormonal yang memengaruhi mikroflora serta integritas jaringan serviks (*Canadian Cancer Society, 2022*). Dalam jangka panjang, trauma ini dapat memperbesar kemungkinan transformasi sel abnormal, terutama jika disertai infeksi HPV.

Status sosial ekonomi rendah juga menjadi salah satu determinan penting dalam epidemiologi kanker serviks. Perempuan dengan akses terbatas terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, dan program deteksi dini seperti Pap smear atau vaksinasi HPV, lebih rentan mengalami keterlambatan diagnosis dan penatalaksanaan. Ketimpangan ini menyebabkan beban penyakit kanker serviks lebih tinggi di negara berkembang, termasuk Indonesia (Globocan, 2020; Bruni et al., 2019).

Gaya hidup yang tidak sehat, seperti merokok, kurangnya konsumsi buah dan sayur, serta kebersihan genital yang buruk turut memperburuk risiko. Zat kimia dalam rokok dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh dan menurunkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi HPV. Selain itu, defisiensi mikronutrien seperti vitamin A, C, dan E juga memengaruhi respons imun terhadap infeksi virus (CDC, 2021). Kebersihan genital yang buruk meningkatkan risiko infeksi menular lainnya yang dapat mempercepat perkembangan lesi serviks menjadi ganas.

Dari aspek epidemiologi global, kanker serviks menempati posisi keempat kanker tersering pada perempuan dengan sekitar 604.000 kasus baru dan 342.000 kematian pada tahun 2020 (WHO, 2022). Sekitar 90% kematian terjadi di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Di Indonesia, kanker serviks menjadi penyebab utama kedua dari seluruh jenis kanker pada wanita setelah kanker payudara, dengan estimasi 36.633 kasus baru dan 21.003 kematian setiap tahun (Globocan, 2020). Kondisi ini menegaskan pentingnya edukasi, promosi kesehatan, dan deteksi dini sebagai upaya utama dalam menekan angka kejadian dan mortalitas akibat kanker serviks.

Gejala Klinis dan Stadium Kanker Serviks

Gejala klinis kanker serviks pada tahap awal umumnya tidak spesifik atau bahkan tidak muncul sama sekali. Inilah yang menyebabkan banyak kasus kanker serviks baru terdiagnosis pada stadium lanjut. Ketika gejala mulai muncul, tanda-tanda yang paling umum meliputi perdarahan pervaginam yang tidak normal, seperti perdarahan setelah hubungan seksual, di luar siklus menstruasi, atau setelah menopause (World Health Organization [WHO], 2022). Selain itu, wanita juga dapat mengalami keputihan berbau tidak sedap, nyeri panggul, atau rasa tidak nyaman saat berhubungan seksual, yang sering kali disalahartikan sebagai infeksi biasa atau gangguan hormonal (Centers for Disease Control and Prevention [CDC], 2021).

Gejala-gejala tersebut berkaitan erat dengan perkembangan lesi kanker pada jaringan serviks dan penyebarannya ke jaringan sekitarnya. Pada stadium lanjut, kanker serviks dapat menyebabkan gejala yang lebih parah seperti nyeri punggung, gangguan buang air kecil atau besar, pembengkakan tungkai, hingga hematuria jika tumor sudah menyebar ke kandung kemih atau organ lainnya (American Cancer Society, 2023). Penyebaran lokal dan metastasis jauh dapat

terjadi melalui jaringan limfatik atau pembuluh darah, sehingga deteksi dini menjadi kunci utama dalam pengendalian penyakit ini. Oleh karena itu, penting bagi perempuan usia subur untuk memahami dan mengenali gejala-gejala awal yang mungkin muncul.

Kanker serviks diklasifikasikan menurut sistem FIGO (International Federation of Gynecology and Obstetrics), yang menetapkan stadium berdasarkan ukuran tumor, kedalaman invasi, dan penyebaran ke jaringan sekitarnya atau organ jauh. Stadium 0 atau karsinoma in situ menggambarkan kondisi prakanker dimana sel-sel abnormal terbatas pada lapisan epitel serviks. Stadium I menunjukkan bahwa kanker terbatas pada serviks, sementara Stadium II mengindikasikan penyebaran ke area sekitar tetapi belum mencapai dinding panggul atau sepertiga bagian bawah vagina. Stadium III menandakan keterlibatan dinding panggul atau sepertiga bawah vagina, dan Stadium IV adalah kondisi paling lanjut dengan penyebaran ke kandung kemih, rektum, atau organ jauh seperti paru-paru (Bhatla et al., 2019). Penentuan stadium sangat penting dalam memilih pendekatan terapi yang tepat, baik berupa pembedahan, radiasi, kemoterapi, maupun kombinasi ketiganya.

Tabel 1.1 Stadium Kanker Serviks dan Gejala-Gejalanya

Stadium	Deskripsi Klinis	Gejala Umum
Stadium 0 (Karsinoma in situ / CIN III)	Sel-sel abnormal terbatas pada epitel serviks, belum menembus membran basal	Umumnya tanpa gejala; ditemukan melalui skrining Pap smear atau HPV DNA
Stadium I	Kanker terbatas pada serviks uteri	Perdarahan pervaginam ringan di luar siklus haid atau setelah hubungan seksual; keputihan abnormal
Stadium II	Kanker menyebar di luar serviks tetapi belum mencapai dinding panggul atau sepertiga bawah vagina	Perdarahan pascakoitus, keputihan berbau busuk, nyeri panggul atau punggung bawah

Stadium III	Kanker meluas ke dinding panggul dan/atau sepertiga bawah vagina, bisa menyebabkan gangguan saluran kemih	Perdarahan hebat, nyeri kronis panggul/pinggang, gangguan BAK (anyang-anyangan atau obstruksi), hematuria
Stadium IV	Kanker menyebar ke kandung kemih, rektum, atau organ jauh (paru-paru, hati)	Nyeri hebat, sembelit kronis, fistula, penurunan berat badan drastis, anemia, nyeri tulang atau gejala sistemik lain

Penentuan stadium kanker serviks dilakukan berdasarkan panduan dari *International Federation of Gynecology and Obstetrics* (FIGO), yang mempertimbangkan temuan klinis, hasil pemeriksaan penunjang, dan pemeriksaan laboratorium. Proses ini mencakup pemeriksaan fisik ginekologis yang teliti, serta penggunaan pencitraan seperti ultrasonografi (USG), computerized tomography (CT scan), dan magnetic resonance imaging (MRI) untuk menilai luasnya penyebaran tumor. Selain itu, prosedur diagnostik seperti biopsi jaringan serviks dan kolposkopi digunakan untuk memastikan diagnosis histopatologis dan membantu menentukan kedalaman invasi sel kanker. Kombinasi dari berbagai metode ini memberikan gambaran menyeluruh yang penting dalam pengambilan keputusan terapi.

Deteksi kanker serviks pada stadium awal memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap prognosis pasien. Pada stadium 0 hingga I, angka harapan hidup relatif tinggi karena kanker masih terbatas di serviks dan respon terhadap pengobatan cukup baik. Sebaliknya, pada stadium lanjut di mana kanker telah menyebar ke organ sekitarnya atau organ jauh, penatalaksanaan menjadi lebih kompleks dengan risiko komplikasi yang lebih besar. Oleh karena itu, penting untuk melakukan skrining secara rutin dan meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama wanita usia subur, agar kanker serviks dapat dikenali dan ditangani sejak dini.

Dampak Kanker Serviks terhadap Kesehatan Wanita

Kanker serviks memberikan dampak biologis yang signifikan terhadap fungsi tubuh wanita, terutama dalam sistem reproduksi dan saluran kemih. Gejala fisik seperti perdarahan pervaginam abnormal, nyeri panggul, keputihan berbau busuk, dan nyeri saat berhubungan seksual menjadi keluhan utama pasien (*World Health Organization* [WHO], 2022). Pada stadium lanjut, sel kanker dapat menyebar ke jaringan sekitar seperti kandung kemih atau rektum, menyebabkan komplikasi seperti hematuria, fistula, dan obstruksi saluran kemih. Efek samping dari pengobatan seperti kemoterapi dan radioterapi juga menyebabkan mual, muntah, kelelahan kronis, dan penurunan nafsu makan, yang secara langsung memengaruhi kualitas hidup pasien (*American Cancer Society*, 2023).

Secara psikologis, diagnosis kanker serviks menimbulkan tekanan emosional berat. Reaksi umum yang dialami pasien meliputi syok, ketakutan, kecemasan, hingga depresi, terutama saat mengetahui bahwa kanker ini berkaitan dengan virus yang ditularkan secara seksual (Zhou et al., 2022). Banyak pasien juga merasa bersalah, malu, dan kehilangan harga diri, terutama jika mereka belum mengetahui bahwa infeksi HPV sangat umum dan bukan semata akibat perilaku menyimpang. Perubahan fisik akibat pengobatan seperti kehilangan rahim atau rambut rontok selama kemoterapi dapat memperburuk citra diri dan membuat pasien menarik diri dari lingkungan sosialnya.

Dari aspek sosial, kanker serviks dapat mengganggu peran wanita dalam keluarga dan komunitas. Banyak pasien yang tidak mampu lagi menjalankan fungsi domestik dan produktif seperti sebelumnya akibat kelelahan, nyeri, atau efek pengobatan jangka panjang (Bruni et al., 2019). Perubahan peran ini dapat menciptakan ketergantungan pada pasangan atau anggota keluarga lain, yang pada beberapa kasus menyebabkan konflik dalam rumah tangga. Selain itu,

dalam budaya tertentu, masih terdapat stigma terhadap penderita kanker serviks yang diasosiasikan secara negatif dengan perilaku seksual, sehingga pasien dapat mengalami diskriminasi atau pengucilan dari lingkungan sosialnya.

Dampak ekonomi juga menjadi tantangan besar bagi perempuan dengan kanker serviks, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Biaya pengobatan kanker yang tinggi—termasuk pemeriksaan diagnostik, operasi, radioterapi, dan kemoterapi—sering kali tidak sepenuhnya ditanggung oleh asuransi atau jaminan kesehatan. Banyak pasien dari kelompok ekonomi menengah ke bawah yang terpaksa menghentikan pengobatan karena keterbatasan dana atau akses fasilitas kesehatan, terutama jika tinggal di daerah terpencil (Globocan, 2020). Ketidakterjangkauan biaya ini bukan hanya memperburuk prognosis pasien, tetapi juga berdampak pada kondisi keuangan keluarga secara keseluruhan.

Dari sisi seksual, kanker serviks dan terapinya sangat memengaruhi fungsi dan kualitas kehidupan seksual perempuan. Radioterapi dan kemoterapi dapat menyebabkan atrofi vagina, penurunan lubrikasi, dan disfungsi seksual seperti dyspareunia, menurunnya libido, dan anorgasmia (Lammerink et al., 2021). Pasien juga mungkin mengalami ketakutan untuk kembali berhubungan intim karena rasa nyeri atau kekhawatiran akan kambuhnya penyakit. Gangguan fungsi seksual ini berdampak besar terhadap relasi emosional dengan pasangan, terutama jika tidak diimbangi dengan komunikasi dan dukungan yang terbuka. Sayangnya, topik kesehatan seksual pascakanker masih sering diabaikan dalam praktik keperawatan dan pelayanan kesehatan.

Untuk itu, pendekatan holistik sangat penting dalam mendampingi perempuan dengan kanker serviks. Tenaga keperawatan tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga harus memberikan dukungan psikologis, edukasi seksual, serta memfasilitasi intervensi sosial yang memberdayakan pasien. Pendekatan ini mencerminkan nilai-nilai asuhan keperawatan yang berorientasi pada kebutuhan individu secara utuh. Edukasi yang komprehensif, konseling keluarga, serta kolaborasi lintas profesi menjadi kunci dalam membantu pasien mempertahankan kualitas hidup yang optimal selama dan setelah pengobatan (WHO, 2022). Kanker serviks bukan hanya masalah medis, melainkan juga tantangan kemanusiaan yang menuntut empati, dukungan, dan advokasi dari seluruh pihak.

BAB 2

WANITA USIA SUBUR (WUS)

Definisi dan Karakteristik Wanita Usia Subur

Wanita usia subur (WUS) adalah kelompok perempuan yang berada dalam rentang usia di mana mereka secara biologis mampu untuk hamil dan melahirkan anak. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan wanita usia subur sebagai perempuan yang berada dalam rentang usia 15 hingga 49 tahun (World Health Organization [WHO], 2022). Pada masa ini, sistem reproduksi wanita berfungsi secara aktif, ditandai dengan adanya siklus menstruasi yang teratur serta kemampuan ovulasi. Kelompok usia ini menjadi sangat penting dalam konteks kesehatan reproduksi karena mereka merupakan populasi utama yang menjadi target berbagai program kesehatan ibu dan anak, termasuk upaya deteksi dini kanker serviks.

Karakteristik wanita usia subur tidak hanya dilihat dari aspek biologis, tetapi juga mencakup dimensi psikososial dan lingkungan. Secara umum, perempuan dalam rentang usia ini berada pada fase aktif dalam pendidikan, pekerjaan, dan peran sosial, serta banyak yang sedang atau telah menikah dan memiliki anak. Tingkat pengetahuan, akses terhadap layanan kesehatan, status gizi, dan perilaku hidup sehat sangat bervariasi dalam kelompok ini, tergantung pada latar belakang pendidikan, ekonomi, dan budaya (Kemenkes, 2021). Oleh karena itu, pendekatan intervensi kesehatan untuk wanita usia subur harus mempertimbangkan konteks sosial dan budaya setempat agar efektif dan berkelanjutan.

Di Indonesia, wanita usia subur (WUS) merupakan kelompok populasi yang signifikan dalam perencanaan dan pelaksanaan program kesehatan reproduksi. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2023, jumlah perempuan dalam kelompok usia 15–49 tahun mencapai lebih dari 70 juta jiwa, mencerminkan proporsi yang besar dalam struktur demografi nasional. Sebagian besar WUS berada dalam rentang usia 20–35 tahun, yang merupakan periode puncak kesuburan dan aktivitas reproduksi. Kelompok usia ini menjadi fokus utama dalam berbagai program kesehatan, termasuk keluarga berencana dan deteksi dini kanker serviks (Jayanti & Pujiati, 2023).

Karakteristik WUS di Indonesia sangat beragam, mencakup aspek pendidikan, pekerjaan, dan status sosial ekonomi. Banyak WUS yang telah menyelesaikan pendidikan hingga tingkat menengah atas atau lebih tinggi, namun masih terdapat kesenjangan akses pendidikan di beberapa daerah. Dalam hal pekerjaan, sebagian besar WUS terlibat dalam sektor informal atau pekerjaan rumah tangga, yang dapat mempengaruhi akses mereka terhadap informasi dan layanan kesehatan. Selain itu, tingkat pengetahuan tentang kesehatan

reproduksi dan pentingnya deteksi dini penyakit seperti kanker serviks masih bervariasi, tergantung pada faktor-faktor seperti pendidikan dan akses informasi. Faktor-faktor seperti paritas (jumlah anak yang dilahirkan), status pernikahan, dan dukungan keluarga juga memainkan peran penting dalam perilaku kesehatan WUS. Penelitian menunjukkan bahwa wanita dengan jumlah anak lebih banyak cenderung lebih sadar akan pentingnya penggunaan kontrasepsi dan pemeriksaan kesehatan rutin. Namun, hambatan seperti stigma sosial, keterbatasan ekonomi, dan kurangnya dukungan dari pasangan atau keluarga dapat menghalangi WUS untuk mengakses layanan kesehatan yang mereka butuhkan. Oleh karena itu, pendekatan yang holistik dan sensitif terhadap konteks sosial budaya sangat diperlukan dalam merancang intervensi kesehatan yang efektif bagi WUS di Indonesia (Mutammimah, Nurjanah, & Nurfita, 2023).

Dalam konteks pelayanan keperawatan dan kesehatan masyarakat, wanita usia subur merupakan kelompok prioritas dalam program-program seperti keluarga berencana, kesehatan ibu hamil, imunisasi HPV, dan deteksi dini kanker serviks. Perempuan dalam kelompok ini juga berisiko mengalami berbagai masalah kesehatan reproduksi, termasuk infeksi menular seksual, kehamilan yang tidak direncanakan, serta komplikasi obstetri (UNFPA, 2022). Pengetahuan dan perilaku mereka terkait kesehatan seksual dan reproduksi menjadi kunci dalam upaya pencegahan penyakit serta peningkatan kualitas hidup secara umum. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai karakteristik dan kebutuhan kesehatan wanita usia subur sangat penting untuk pengembangan intervensi yang tepat sasaran oleh tenaga kesehatan, khususnya perawat.

Kesehatan Reproduksi pada WUS

Kesehatan reproduksi pada wanita usia subur (WUS) merupakan aspek penting dalam upaya meningkatkan kualitas hidup perempuan dan keluarga. WUS, yang berada dalam rentang usia 15–49 tahun, mengalami berbagai perubahan biologis dan sosial yang memengaruhi kesehatan reproduksinya. Perhatian terhadap kesehatan reproduksi pada kelompok ini sangat penting karena mereka berada pada fase aktif dalam kehidupan reproduktif, termasuk menstruasi, kehamilan, persalinan, dan menyusui. Oleh karena itu, pemahaman dan perawatan yang tepat terhadap kesehatan reproduksi menjadi krusial untuk mencegah berbagai masalah kesehatan yang dapat berdampak jangka panjang.

Salah satu aspek penting dalam kesehatan reproduksi WUS adalah pemeliharaan kebersihan organ reproduksi. Personal hygiene yang baik, terutama selama menstruasi dan masa subur, dapat mencegah infeksi dan gangguan kesehatan lainnya. Edukasi mengenai perawatan genitalia yang benar, seperti penggunaan pembalut yang bersih dan penggantian pakaian dalam secara rutin, telah terbukti meningkatkan pengetahuan dan kesadaran WUS dalam menjaga kesehatan reproduksinya (UNFPA Indonesia, 2021). Peningkatan pengetahuan ini diharapkan dapat mendorong perilaku hidup bersih dan sehat yang berkelanjutan (Astuti, 2021).

Program keluarga berencana (KB) juga memainkan peran penting dalam kesehatan reproduksi WUS. Penggunaan kontrasepsi yang tepat dapat membantu mengatur jarak kelahiran, mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, dan mengurangi risiko komplikasi kehamilan. Data menunjukkan bahwa sebagian besar WUS di Indonesia menggunakan kontrasepsi hormonal, seperti suntik dan pil, sebagai metode KB. Namun, masih diperlukan edukasi

lebih lanjut mengenai pilihan kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi kesehatan dan kebutuhan individu Rahmawati & Wijaya, 2024).

Deteksi dini terhadap penyakit reproduksi, seperti kanker serviks dan kanker payudara, sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanganan penyakit secara efektif. Pemeriksaan rutin, seperti Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA) dan pemeriksaan payudara sendiri (SADARI), dapat membantu WUS dalam mengenali tanda-tanda awal penyakit dan segera mencari penanganan medis. Sayangnya, masih banyak WUS yang kurang memahami pentingnya deteksi dini dan merasa enggan untuk melakukan pemeriksaan karena berbagai alasan, termasuk rasa malu dan kurangnya informasi. Oleh karena itu, perlu adanya upaya edukasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi WUS dalam program deteksi dini (Syalfina, Irawati, Priyani, & Sulistyawati, 2022)

Kesehatan reproduksi WUS juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi. Akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, pendidikan, dan informasi yang akurat sangat menentukan kemampuan WUS dalam menjaga kesehatan reproduksinya. Program edukasi dan penyuluhan yang disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya setempat dapat membantu mengatasi hambatan-hambatan ini. Selain itu, dukungan dari keluarga dan komunitas juga berperan penting dalam mendorong WUS untuk aktif menjaga kesehatan reproduksinya.

Pemerintah dan berbagai organisasi kesehatan telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesehatan reproduksi WUS di Indonesia. Program-program seperti penyuluhan kesehatan, pelayanan KB, dan pemeriksaan kesehatan gratis telah dilaksanakan di berbagai daerah. Namun, tantangan masih tetap ada, terutama dalam menjangkau WUS di daerah terpencil dan meningkatkan kualitas

layanan kesehatan. Kerjasama antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan ini dan memastikan bahwa semua WUS mendapatkan layanan kesehatan reproduksi yang optimal.

Secara keseluruhan, kesehatan reproduksi pada WUS merupakan aspek yang kompleks dan multidimensional, melibatkan faktor biologis, psikologis, sosial, dan ekonomi. Pendekatan yang holistik dan terintegrasi diperlukan untuk memastikan bahwa WUS dapat menjalani kehidupan reproduktif yang sehat dan produktif. Edukasi, pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan dukungan sosial merupakan komponen kunci dalam upaya meningkatkan kesehatan reproduksi WUS. Dengan demikian, investasi dalam kesehatan reproduksi WUS akan memberikan dampak positif yang luas bagi individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan.

Masalah Kesehatan yang Sering Terjadi pada WUS

Wanita usia subur (WUS), yang berada dalam rentang usia 15–49 tahun, menghadapi berbagai tantangan kesehatan yang dapat memengaruhi kualitas hidup dan produktivitas mereka. Masalah-masalah ini mencakup aspek fisik, reproduksi, dan mental, serta dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi. Pemahaman terhadap masalah-masalah kesehatan yang umum terjadi pada WUS sangat penting untuk merancang intervensi yang efektif dan tepat sasaran. Salah satu masalah kesehatan yang sering dialami oleh WUS adalah anemia defisiensi besi. Data menunjukkan bahwa prevalensi anemia pada WUS di Indonesia mencapai 30,6%, dengan angka yang lebih tinggi pada remaja putri. Anemia dapat menyebabkan kelelahan, penurunan konsentrasi, dan risiko komplikasi selama kehamilan, seperti kelahiran prematur dan berat badan lahir rendah. Faktor penyebab anemia antara lain asupan zat besi yang tidak

mencukupi, menstruasi yang berat, dan infeksi cacing tambang (Kementerian Kesehatan RI, 2018).

Infeksi menular seksual (IMS) juga merupakan masalah kesehatan yang signifikan pada WUS. Penyakit seperti gonore, sifilis, klamidia, dan trikomoniasis dapat menyebabkan komplikasi serius, termasuk infertilitas dan peningkatan risiko infeksi HIV. Kurangnya pengetahuan tentang IMS dan perilaku seksual berisiko, seperti berganti-ganti pasangan tanpa penggunaan kondom, meningkatkan kerentanan WUS terhadap IMS. Upaya edukasi dan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang ramah sangat diperlukan untuk menurunkan angka kejadian IMS (*World Health Organization*, 2016).

Kanker serviks menjadi salah satu penyebab utama kematian akibat kanker pada perempuan di Indonesia. Infeksi Human Papillomavirus (HPV) merupakan faktor risiko utama, dan deteksi dini melalui skrining seperti tes IVA atau Pap smear sangat penting. Namun, cakupan skrining di Indonesia masih rendah, dengan hanya sekitar 7,02% perempuan usia 30–50 tahun yang menjalani pemeriksaan pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran dan akses terhadap layanan skrining kanker serviks (Kementerian Kesehatan RI, 2023).

Masalah kesehatan mental, termasuk depresi dan kecemasan, juga sering dialami oleh WUS. Faktor-faktor seperti tekanan sosial, beban ganda antara pekerjaan dan keluarga, serta pengalaman kekerasan dapat memengaruhi kesehatan mental perempuan. Studi menunjukkan bahwa perempuan lebih rentan mengalami gangguan mental dibandingkan laki-laki, dengan prevalensi depresi sebesar 2,9% dan kecemasan 4,5% di Indonesia. Dukungan sosial dan akses terhadap layanan kesehatan mental yang terjangkau sangat penting untuk mengatasi masalah ini (Institute for Health Metrics and Evaluation, 2019).

Kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) merupakan masalah kesehatan reproduksi yang berdampak luas pada WUS. KTD dapat menyebabkan stres, aborsi tidak aman, dan komplikasi kesehatan lainnya. Faktor penyebab KTD antara lain kurangnya pengetahuan tentang kontrasepsi, akses terbatas terhadap layanan keluarga berencana, dan norma sosial yang membatasi otonomi perempuan dalam pengambilan keputusan reproduktif. Peningkatan edukasi dan akses terhadap layanan kontrasepsi yang berkualitas dapat membantu menurunkan angka KTD (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2020).

Masalah gizi, seperti kekurangan energi kronis (KEK), juga sering terjadi pada WUS, terutama di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi. KEK dapat menyebabkan gangguan fungsi reproduksi, peningkatan risiko komplikasi kehamilan, dan dampak negatif pada pertumbuhan janin. Faktor penyebab KEK meliputi asupan makanan yang tidak mencukupi, pola makan yang tidak seimbang, dan infeksi kronis. Intervensi gizi yang tepat dan edukasi tentang pola makan sehat sangat penting untuk mengatasi masalah ini (Kementerian Kesehatan RI, 2018).

Secara keseluruhan, berbagai masalah kesehatan yang sering terjadi pada WUS memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi. Kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kesadaran, akses, dan kualitas layanan kesehatan bagi WUS. Investasi dalam kesehatan WUS tidak hanya meningkatkan kesejahteraan individu, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

Perilaku Pencegahan Kanker Serviks pada Wanita Usia Subur

Kanker serviks merupakan salah satu penyebab utama kematian akibat kanker pada wanita di Indonesia. Wanita usia subur (15–49 tahun) merupakan kelompok yang paling rentan terhadap penyakit ini. Meskipun kanker serviks dapat dicegah melalui berbagai upaya, tingkat adopsi perilaku pencegahan di kalangan WUS masih rendah. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan mendorong perilaku pencegahan yang efektif di kalangan WUS.

1. Pencegahan Primer: Vaksinasi HPV dan Edukasi Kesehatan

Pencegahan primer bertujuan untuk mencegah infeksi Human Papillomavirus (HPV), penyebab utama kanker serviks. Vaksinasi HPV merupakan langkah efektif dalam pencegahan ini. Namun, cakupan vaksinasi di Indonesia masih rendah, terutama di kalangan WUS. Faktor-faktor seperti kurangnya informasi, biaya, dan aksesibilitas menjadi hambatan utama. Edukasi kesehatan yang menyeluruh dan program vaksinasi yang terjangkau dapat meningkatkan partisipasi WUS dalam pencegahan primer.

2. Pencegahan Sekunder: Skrining Rutin dan Deteksi Dini

Pencegahan sekunder melibatkan deteksi dini melalui skrining rutin, seperti tes Pap smear dan Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA). Skrining ini penting untuk mengidentifikasi perubahan sel serviks sebelum berkembang menjadi kanker. Namun, tingkat partisipasi WUS dalam skrining masih rendah, sebagian besar disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan kesadaran. Program edukasi yang menekankan pentingnya skrining rutin dapat meningkatkan perilaku pencegahan sekunder di kalangan WUS.

3. Pencegahan Tersier: Pengobatan dan Rehabilitasi

Pencegahan tersier fokus pada pengobatan dan rehabilitasi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut pada pasien yang telah didiagnosis

dengan kanker serviks. WUS yang menerima pengobatan tepat waktu dan dukungan rehabilitasi memiliki peluang lebih baik untuk pemulihan. Namun, stigma sosial dan kurangnya dukungan psikologis seringkali menghambat proses ini. Penting untuk menyediakan layanan kesehatan yang komprehensif, termasuk dukungan psikososial, bagi WUS yang menjalani pengobatan kanker serviks.

4. Perilaku Sehat: Gaya Hidup dan Kebiasaan Sehari-hari

Selain intervensi medis, perilaku sehari-hari seperti menjaga kebersihan organ reproduksi, menghindari merokok, dan menerapkan pola hidup sehat juga berperan penting dalam pencegahan kanker serviks. WUS yang menerapkan gaya hidup sehat memiliki risiko lebih rendah terhadap perkembangan kanker serviks. Edukasi mengenai pentingnya perilaku sehat harus menjadi bagian integral dari program pencegahan kanker serviks.

Dukungan Sosial dan Keluarga

Dukungan dari keluarga dan lingkungan sosial sangat mempengaruhi perilaku pencegahan WUS. WUS yang mendapatkan dukungan dari pasangan dan keluarga cenderung lebih aktif dalam melakukan tindakan pencegahan. Program komunitas yang melibatkan keluarga dalam edukasi kesehatan dapat memperkuat perilaku pencegahan di kalangan WUS.

Perilaku pencegahan kanker serviks pada WUS mencakup berbagai aspek, mulai dari vaksinasi, skrining rutin, hingga penerapan gaya hidup sehat. Untuk meningkatkan perilaku pencegahan ini, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan edukasi, akses layanan kesehatan, dan dukungan sosial. Dengan upaya bersama, diharapkan angka kejadian kanker serviks di kalangan WUS dapat ditekan secara signifikan.

Tantangan Deteksi Dini Kanker Serviks di Kalangan WUS

Kanker serviks merupakan salah satu penyebab utama kematian akibat kanker pada wanita di seluruh dunia, terutama di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Deteksi dini melalui skrining rutin seperti tes Pap smear, Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA), dan tes HPV telah terbukti efektif dalam menurunkan angka kejadian dan kematian akibat kanker serviks (WHO, 2022). Namun, berbagai tantangan masih menghambat pelaksanaan deteksi dini, khususnya di kalangan wanita usia subur (WUS). Tantangan-tantangan ini bervariasi di setiap wilayah, mulai dari kendala struktural hingga hambatan budaya dan sosial.

Secara global, sekitar 600.000 kasus baru kanker serviks didiagnosis setiap tahun, dengan lebih dari 300.000 kematian, sebagian besar terjadi di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Tantangan utama dalam deteksi dini meliputi keterbatasan akses terhadap layanan skrining, kurangnya tenaga medis terlatih, dan infrastruktur kesehatan yang tidak memadai. Selain itu, stigma sosial dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya skrining juga menjadi penghambat signifikan (*Cancer Today*, 2022).

Di Asia, tantangan dalam deteksi dini kanker serviks mencakup rendahnya tingkat partisipasi dalam program skrining, terutama di kalangan wanita dari kelompok etnis minoritas dan berpendapatan rendah. Faktor-faktor seperti kurangnya pengetahuan tentang kanker serviks, hambatan bahasa, dan norma budaya yang menganggap pemeriksaan organ reproduksi sebagai hal yang tabu turut berkontribusi terhadap rendahnya partisipasi. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan infrastruktur kesehatan di beberapa negara Asia juga menghambat pelaksanaan program skrining yang efektif (Lee, 2011; Wong, 2021).

Di Indonesia, tantangan dalam deteksi dini kanker serviks di kalangan WUS meliputi rendahnya tingkat kesadaran dan pengetahuan tentang pentingnya skrining, serta adanya rasa malu dan takut untuk menjalani pemeriksaan. Studi menunjukkan bahwa banyak wanita usia subur yang enggan melakukan tes IVA atau Pap smear karena merasa malu atau takut terhadap hasil pemeriksaan (Kemenkes, 2013). Selain itu, keterbatasan tenaga medis terlatih dan fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan skrining juga menjadi hambatan signifikan (Lestari & Wahyuni, 2018).

Deteksi dini kanker serviks merupakan langkah krusial dalam upaya menurunkan angka kejadian dan kematian akibat penyakit ini, khususnya di kalangan wanita usia subur. Namun, berbagai tantangan, baik secara global, di Asia, maupun di Indonesia, masih menghambat pelaksanaan program skrining yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut melalui peningkatan edukasi, penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai, dan penghapusan stigma sosial terkait pemeriksaan kesehatan reproduksi.

Peran Tenaga Kesehatan dalam Edukasi WUS tentang Kanker Serviks

Kanker serviks merupakan salah satu penyebab utama kematian akibat kanker pada wanita di seluruh dunia, terutama di negara-negara berkembang. Wanita usia subur (WUS) menjadi kelompok yang rentan terhadap penyakit ini. Edukasi yang efektif tentang pencegahan dan deteksi dini kanker serviks sangat penting untuk menurunkan angka kejadian dan kematian. Tenaga kesehatan memiliki peran sentral dalam memberikan edukasi tersebut.

1. Peran Tenaga Kesehatan dalam Edukasi Kanker Serviks

Tenaga kesehatan seperti perawat, bidan, dan dokter umum adalah garda terdepan dalam memberikan informasi kepada wanita usia subur mengenai pencegahan kanker serviks. Mereka berperan dalam menyampaikan edukasi tentang faktor risiko (seperti infeksi HPV dan perilaku seksual berisiko), pentingnya vaksinasi HPV, dan manfaat deteksi dini melalui skrining seperti Pap smear dan Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA). Edukasi ini dapat diberikan melalui berbagai bentuk, seperti konseling individu saat pelayanan rutin, penyuluhan kelompok di puskesmas, atau kegiatan luar gedung seperti posyandu dan pengajian. Efektivitas edukasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan komunikasi tenaga kesehatan, termasuk dalam menyampaikan informasi dengan bahasa yang mudah dipahami, sensitif terhadap budaya, dan tanpa menghakimi (Wigatia et al., 2023). Jika tenaga kesehatan dapat memberikan informasi secara konsisten dan empatik, maka pengetahuan, sikap, dan praktik WUS akan meningkat secara signifikan.

2. Tantangan Global dalam Edukasi Kanker Serviks

Secara global, tantangan utama dalam edukasi kanker serviks adalah keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur kesehatan. Di banyak negara berpenghasilan rendah dan menengah, jumlah tenaga kesehatan yang tersedia tidak sebanding dengan beban populasi yang harus dilayani. Akibatnya, prioritas layanan lebih diarahkan pada kuratif daripada promotif dan preventif, sehingga waktu dan tenaga untuk melakukan edukasi menjadi sangat terbatas (WHO, 2022). Di sisi lain, pelatihan spesifik terkait komunikasi risiko kanker serviks dan teknik edukasi berbasis komunitas belum menjadi bagian wajib dari kurikulum kedokteran atau keperawatan di banyak negara. Hal ini membuat tenaga kesehatan kurang percaya diri dalam membahas topik sensitif seperti infeksi menular seksual dan vaksin HPV, padahal topik tersebut sangat krusial dalam konteks pencegahan kanker serviks (Medical

Channel Asia, 2024). Edukasi massal juga belum merata dan sering kali tidak berkelanjutan karena bergantung pada dukungan donor atau lembaga luar.

3. Tantangan Edukasi di Asia

Tantangan edukasi kanker serviks di kawasan Asia sangat dipengaruhi oleh kompleksitas budaya, sosial, dan ketimpangan sistem layanan kesehatan. Di banyak negara Asia, termasuk Asia Selatan dan Asia Tenggara, pembicaraan terbuka tentang kesehatan reproduksi masih dianggap tabu, bahkan dalam konteks edukasi medis. Norma sosial yang konservatif membuat banyak wanita merasa malu atau tidak pantas mendiskusikan topik seputar organ genital, hubungan seksual, atau skrining serviks, bahkan kepada tenaga kesehatan. Akibatnya, WUS sering kali tidak menerima informasi yang mereka butuhkan karena enggan bertanya atau merasa topik tersebut terlalu pribadi.

Dalam konteks ini, peran tenaga kesehatan menjadi sangat menantang. Edukasi kanker serviks yang idealnya bersifat dialogis sering kali terhambat oleh keengganan pasien untuk berbicara, serta kurangnya pelatihan tenaga kesehatan dalam menghadapi isu budaya yang sensitif. Beberapa studi di India, Pakistan, dan Filipina menunjukkan bahwa meskipun tenaga kesehatan memahami pentingnya edukasi, mereka kerap kesulitan membangun hubungan yang nyaman dengan pasien karena perbedaan usia, gender, atau latar belakang budaya (Wong et al., 2021). Hal ini menyebabkan pesan edukasi tidak sampai secara utuh dan justru menambah jarak antara pasien dan penyedia layanan.

Tantangan lain yang signifikan adalah kesenjangan literasi kesehatan. Di banyak negara Asia, terutama di komunitas pedesaan atau minoritas etnis, tingkat pendidikan dasar masih rendah, sehingga WUS sulit memahami

informasi medis dalam bentuk teks maupun lisan. Penggunaan istilah medis yang rumit atau bahasa nasional yang tidak familiar menjadi penghalang dalam komunikasi. Oleh karena itu, dibutuhkan tenaga kesehatan yang mampu menyesuaikan cara penyampaian materi edukasi dengan bahasa lokal dan konteks budaya agar pesan dapat diterima secara efektif.

Selain hambatan budaya dan literasi, masih terdapat kesenjangan dalam distribusi sumber daya edukasi dan infrastruktur kesehatan. Beberapa negara Asia belum memiliki sistem yang kuat untuk pelatihan tenaga kesehatan dalam komunikasi kesehatan masyarakat. Materi edukatif seperti leaflet, video, atau modul visual masih terbatas dan belum tersedia dalam berbagai bahasa lokal. Banyak kampanye edukasi yang bersifat sekali jalan, tidak berkelanjutan, atau tidak berbasis kebutuhan komunitas. Akibatnya, efek edukasi bersifat sementara dan tidak mendorong perubahan perilaku jangka panjang.

Di sisi lain, negara-negara Asia dengan sistem kesehatan yang lebih maju seperti Jepang, Korea Selatan, dan Singapura telah mengembangkan pendekatan edukasi berbasis teknologi dan sistematis. Namun, bahkan di negara-negara tersebut, tingkat vaksinasi HPV dan skrining masih belum maksimal karena masih adanya kekhawatiran masyarakat terkait efek samping, serta kurangnya informasi yang disebarkan secara proaktif oleh penyedia layanan kesehatan (Lee et al., 2011). Ini menunjukkan bahwa tantangan edukasi kanker serviks di Asia bukan hanya soal sumber daya, tetapi juga soal strategi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan.

4. Tantangan Edukasi di Indonesia

Di Indonesia, tantangan edukasi kanker serviks terhadap wanita usia subur (WUS) sangat kompleks dan saling berkaitan. Meskipun pemerintah telah menetapkan deteksi dini kanker serviks melalui IVA test sebagai bagian dari program nasional, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi banyak kendala. Salah satu hambatan utama adalah masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman WUS tentang kanker serviks, penyebabnya, serta pentingnya deteksi dini. Banyak WUS belum mengenal istilah HPV, tidak memahami bahwa infeksi tersebut dapat menyebabkan kanker serviks, atau bahkan tidak mengetahui bahwa deteksi dini bisa dilakukan secara gratis di fasilitas kesehatan tertentu (Kementerian Kesehatan RI, 2023).

Selain itu, pendekatan edukasi oleh tenaga kesehatan di Indonesia sering kali masih bersifat informatif satu arah, belum partisipatif atau dialogis. Penyuluhan dilakukan secara singkat saat antrean di puskesmas atau dalam bentuk ceramah yang tidak memperhatikan latar belakang sosial dan budaya audiens. Akibatnya, banyak informasi yang tidak diterima secara utuh atau bahkan diabaikan karena dianggap tidak relevan. Padahal, pendekatan edukatif yang bersifat kontekstual dan empatik sangat penting dalam isu sensitif seperti kanker serviks yang berhubungan erat dengan kesehatan seksual dan reproduksi (Wuriningsih et al., 2021).

Norma sosial dan budaya juga menjadi tantangan besar. Banyak WUS merasa malu atau tabu untuk berbicara mengenai organ reproduksi, apalagi menjalani pemeriksaan serviks. Beberapa wanita merasa tidak nyaman membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan vagina, HPV, atau hubungan seksual, terlebih jika edukasi dilakukan oleh tenaga kesehatan laki-laki atau dalam forum terbuka. Stigma bahwa kanker serviks hanya menyerang

perempuan “nakal” atau yang sering berganti pasangan masih cukup kuat di masyarakat, sehingga banyak wanita enggan mencari informasi atau mengikuti program skrining. Ini menjadi hambatan psikososial yang serius dalam edukasi kesehatan (Jannah & Hanum, 2025).

Dari sisi tenaga kesehatan sendiri, tidak semua perawat, bidan, atau dokter memiliki pelatihan yang memadai dalam hal edukasi kanker serviks. Kurangnya pelatihan komunikasi risiko, rendahnya pemahaman mengenai pentingnya literasi kesehatan, dan beban kerja yang tinggi membuat edukasi seringkali menjadi prioritas rendah dalam pelayanan sehari-hari. Ditambah lagi, belum semua fasilitas layanan kesehatan menyediakan materi edukatif yang terstandar dan mudah dipahami, baik dalam bentuk leaflet, video, atau infografik. Padahal, ketersediaan media edukasi visual dan komunikasi interpersonal yang efektif sangat diperlukan agar pesan kesehatan dapat tersampaikan dengan baik (Wigatia et al., 2023).

Di daerah terpencil dan kepulauan, tantangan semakin besar karena keterbatasan jumlah tenaga kesehatan, jauhnya jarak ke fasilitas kesehatan, dan minimnya akses terhadap teknologi informasi. WUS di wilayah ini umumnya belum pernah mendapatkan edukasi tentang kanker serviks, bahkan belum pernah mendengar istilah Pap smear atau HPV. Kurangnya kampanye kesehatan reproduksi yang terjangkau dan berkelanjutan membuat kesenjangan informasi semakin lebar. Oleh karena itu, strategi edukasi di Indonesia harus memperhatikan kondisi geografis, sosial-budaya, dan sumber daya setempat untuk menjangkau seluruh kelompok WUS secara adil dan menyeluruh.

BAB 3

PENTINGNYA DETEKSI DINI KANKER SERVIKS

Pengertian Deteksi Dini Kanker Serviks

Deteksi dini kanker serviks merupakan proses untuk menemukan kelainan sel pada serviks sejak tahap prakanker, sebelum berubah menjadi kanker invasif. Langkah ini dilakukan pada wanita yang belum menunjukkan gejala, dengan tujuan agar penanganan dapat dilakukan sedini mungkin untuk mencegah perkembangan penyakit lebih lanjut. Deteksi dini sangat penting karena kanker serviks umumnya berkembang secara perlahan dan tidak menunjukkan tanda-tanda klinis pada tahap awal (World Health Organization [WHO], 2022). Dengan intervensi tepat waktu, lesi prakanker dapat diobati, dan peluang kesembuhan menjadi sangat tinggi.

Metode deteksi dini yang umum digunakan antara lain adalah Pap smear, Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA), dan pemeriksaan DNA Human Papillomavirus (HPV). Pap smear merupakan pemeriksaan sitologi serviks untuk mendeteksi perubahan sel yang mencurigakan, sedangkan IVA adalah metode sederhana dan murah yang menggunakan asam asetat 3–5% untuk mengamati perubahan warna pada jaringan serviks. Tes HPV merupakan metode molekuler yang mendeteksi adanya infeksi virus HPV tipe risiko tinggi yang berpotensi menyebabkan kanker serviks. Pemilihan metode deteksi disesuaikan dengan sumber daya lokal, kebijakan kesehatan nasional, dan ketersediaan tenaga serta fasilitas (Bhatla et al., 2021; WHO, 2021).

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah menetapkan program deteksi dini kanker serviks sebagai bagian dari pelayanan kesehatan primer, dengan metode utama Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA). Program ini menargetkan perempuan usia 30–50 tahun untuk melakukan pemeriksaan secara berkala. Namun, hingga tahun 2023, cakupan skrining kanker serviks di Indonesia baru mencapai 7,02% dari target 70%, menunjukkan bahwa pelaksanaan program ini masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan (Kementerian Kesehatan RI, 2023).

Di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung, fasilitas kesehatan yang lebih lengkap dan tenaga medis yang lebih banyak memungkinkan pelaksanaan program deteksi dini kanker serviks dengan lebih optimal. Puskesmas dan rumah sakit di kota-kota ini umumnya telah menyediakan layanan IVA dan Pap smear, serta memiliki program edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat. Namun, meskipun infrastruktur memadai, tantangan tetap ada, seperti kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dini dan

adanya stigma sosial terkait pemeriksaan organ reproduksi (Universitas Indonesia, 2023).

Di provinsi-provinsi pelosok, seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur, pelaksanaan program deteksi dini kanker serviks menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Keterbatasan infrastruktur, akses transportasi yang sulit, dan kekurangan tenaga medis terlatih menjadi hambatan utama. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya deteksi dini kanker serviks turut mempengaruhi rendahnya partisipasi dalam program skrining. Sebagai contoh, di Kabupaten Bengkalis, Riau, kegiatan pemeriksaan IVA gratis yang diselenggarakan oleh TP PKK setempat menunjukkan antusiasme masyarakat, namun cakupan masih terbatas dan perlu ditingkatkan melalui program yang berkelanjutan (Diskominfotik Bengkalis, 2025).

Keuntungan dan Pentingnya Deteksi Dini

Deteksi dini kanker serviks adalah komponen esensial dalam strategi pengendalian kanker secara global. Kanker serviks umumnya berkembang secara perlahan, dimulai dari perubahan prakanker yang dapat berlangsung selama bertahun-tahun sebelum menjadi ganas. Oleh karena itu, keberhasilan program deteksi dini memungkinkan identifikasi lesi prakanker (seperti *Cervical Intraepithelial Neoplasia/CIN*) dan penanganan dini sebelum berkembang menjadi kanker invasif (WHO, 2021). Dengan intervensi yang tepat pada tahap prakanker, 80–90% kasus kanker serviks dapat dicegah (Bhatla et al., 2019), menjadikan deteksi dini sebagai salah satu intervensi paling cost-effective dalam onkologi wanita.

Keuntungan deteksi dini bukan hanya dari sisi medis, tetapi juga dari segi sosial dan ekonomi. Pengobatan kanker serviks pada stadium lanjut memerlukan terapi multimodal seperti kemoterapi, radioterapi, bahkan operasi radikal, yang secara signifikan lebih mahal dan kompleks. Di sisi lain, ketika kanker ditemukan pada tahap awal, penanganan dapat dilakukan dengan metode yang lebih ringan seperti krioterapi, LEEP (loop electrosurgical excision procedure), atau konisasi, dengan angka keberhasilan yang tinggi dan efek samping yang minimal (*American Cancer Society*, 2023). Ini berdampak langsung pada efisiensi penggunaan sumber daya kesehatan, mengurangi beban biaya pengobatan, serta menghindarkan pasien dari komplikasi jangka panjang yang menurunkan kualitas hidup.

Secara psikososial, deteksi dini memungkinkan perempuan mengetahui kondisi kesehatannya secara proaktif dan mengurangi ketidakpastian yang sering menyertai penyakit kanker. Kesiapan mental dan pengambilan keputusan terapeutik akan lebih baik jika pasien terlibat sejak tahap awal diagnosis. Selain itu, perempuan yang terdeteksi lebih awal cenderung mampu mempertahankan peran sosial, ekonomi, dan keluarga mereka karena tidak perlu menjalani pengobatan jangka panjang yang melelahkan. Program deteksi dini juga membuka ruang edukasi yang lebih luas bagi masyarakat, mendorong peningkatan literasi kesehatan reproduksi serta menumbuhkan budaya skrining rutin sebagai bagian dari gaya hidup sehat (UNFPA, 2022). Dengan demikian, deteksi dini tidak hanya menyelamatkan nyawa, tetapi juga menjaga keseimbangan fungsional perempuan dalam kehidupan sehari-hari.

Jenis dan Metode Deteksi Dini Kanker Serviks

Deteksi dini kanker serviks menjadi salah satu pilar penting dalam strategi pencegahan dan pengendalian kanker secara nasional dan global. Keberhasilan deteksi dini sangat bergantung pada metode skrining yang digunakan serta ketersediaan layanan yang dapat diakses oleh seluruh kelompok wanita usia subur (WUS). Di Indonesia, dua metode utama yang digunakan dalam deteksi dini adalah **Pap smear** dan **Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA)**. Kedua metode ini memiliki karakteristik, prosedur, serta keunggulan masing-masing, dan telah direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan serta WHO sebagai bagian dari pendekatan skrining kanker serviks berbasis populasi.

Pemahaman terhadap mekanisme kerja, kelebihan, dan keterbatasan masing-masing metode sangat penting bagi tenaga kesehatan agar dapat memberikan edukasi dan layanan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Melalui pemeriksaan Pap smear dan IVA yang dilakukan secara rutin dan berkala, perubahan sel abnormal pada leher rahim dapat terdeteksi sedini mungkin sebelum berkembang menjadi kanker. Oleh karena itu, dalam subbab ini akan dibahas secara rinci mengenai kedua metode tersebut sebagai fondasi dalam membangun praktik deteksi dini yang efektif dan berkelanjutan.

1. Pap Smear

Pap smear, atau *Papanicolaou test*, adalah salah satu metode deteksi dini kanker serviks yang paling umum digunakan secara global. Prosedur ini dilakukan dengan mengambil sampel sel dari permukaan luar serviks (ektoserviks) dan kanal serviks (endoserviks) menggunakan spatula kecil dan sikat halus. Sampel kemudian dikirim ke laboratorium untuk dianalisis secara mikroskopik guna mendeteksi adanya sel-sel abnormal, termasuk lesi prakanker seperti CIN 1–3 (*Cervical Intraepithelial Neoplasia*). Prosedur ini tidak membutuhkan waktu lama dan

biasanya tidak menimbulkan rasa sakit, hanya sedikit rasa tidak nyaman selama pengambilan sampel.

Pap smear disarankan untuk wanita usia 21–65 tahun yang sudah aktif secara seksual, dengan frekuensi setiap 3 tahun jika hasil normal. Bila digabungkan dengan tes HPV (co-testing), interval dapat diperpanjang menjadi setiap 5 tahun. Kelebihan Pap smear adalah sensitivitas yang tinggi untuk deteksi sel prakanker, serta mampu mengidentifikasi infeksi dan inflamasi serviks. Namun, kekurangannya adalah ketergantungan pada ketersediaan laboratorium, biaya yang relatif lebih tinggi, serta waktu tunggu hasil yang lebih lama. Pelaksanaan Pap smear paling optimal dilakukan di fasilitas kesehatan sekunder atau tersier dengan tenaga medis terlatih (CDC, 2021; WHO, 2021).

2. Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA)

IVA merupakan metode skrining yang lebih sederhana, praktis, dan ekonomis. Prosedur IVA dilakukan dengan mengoleskan larutan asam asetat 3–5% langsung ke permukaan serviks selama 1–2 menit menggunakan kapas atau kasa steril. Setelah itu, tenaga kesehatan akan mengamati perubahan warna pada serviks. Jika terdapat area epitel yang berubah menjadi putih (acetowhite area), hal ini menunjukkan adanya kemungkinan lesi prakanker yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut atau terapi.

Kelebihan utama dari IVA adalah hasilnya dapat langsung diketahui saat pemeriksaan (see-and-treat approach), tidak memerlukan laboratorium, dan dapat dilakukan oleh bidan atau perawat terlatih di layanan primer. IVA sangat sesuai diterapkan di puskesmas atau klinik di wilayah dengan keterbatasan fasilitas diagnostik dan laboratorium. Meski demikian, IVA memiliki kelemahan berupa sensitivitas dan spesifisitas yang lebih rendah

dibandingkan Pap smear atau tes HPV, serta risiko false positive dan false negative yang lebih tinggi (Sankaranarayanan et al., 2013). Untuk itu, pelatihan dan supervisi tenaga kesehatan menjadi kunci untuk meningkatkan akurasi pemeriksaan IVA.

3. Tes DNA Human Papillomavirus (HPV DNA Test)

Tes HPV DNA merupakan salah satu metode deteksi dini kanker serviks yang paling mutakhir dan direkomendasikan WHO sebagai skrining utama di banyak negara, terutama pada wanita usia 30 tahun ke atas. Prosedur ini bertujuan untuk mendeteksi keberadaan DNA dari tipe-tipe HPV berisiko tinggi, terutama HPV tipe 16 dan 18, yang bertanggung jawab atas lebih dari 70% kasus kanker serviks. Sampel biasanya diambil dari serviks menggunakan alat swab, kemudian dianalisis di laboratorium dengan teknik molekuler untuk mengetahui ada tidaknya infeksi HPV tipe ganas. Tes ini memiliki sensitivitas yang sangat tinggi dalam mendeteksi risiko kanker serviks, bahkan sebelum perubahan sel abnormal terjadi.

Keunggulan utama dari tes HPV DNA adalah kemampuannya mendeteksi infeksi berisiko tinggi jauh sebelum terjadi perubahan sitologis, sehingga memungkinkan intervensi lebih awal dan lebih preventif. Tes ini juga dapat dilakukan dengan metode swab mandiri (*self-sampling*), yang secara signifikan meningkatkan kenyamanan dan partisipasi wanita dalam program skrining. Namun, keterbatasannya adalah biaya yang relatif lebih tinggi dan kebutuhan akan fasilitas laboratorium yang canggih. Oleh karena itu, pelaksanaannya lebih sesuai di daerah dengan infrastruktur kesehatan yang sudah maju atau pada populasi khusus yang membutuhkan skrining yang sangat sensitif (WHO, 2021; Bhatla et al., 2021).

Pemilihan metode deteksi dini kanker serviks harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti efektivitas, sumber daya lokal, kenyamanan pasien, serta ketersediaan fasilitas kesehatan. IVA cocok diterapkan di wilayah dengan keterbatasan sumber daya karena murah, praktis, dan hasil dapat langsung diketahui. Pap smear efektif di wilayah dengan laboratorium memadai dan tenaga terlatih, sementara tes HPV DNA menawarkan akurasi tinggi dan keunggulan dalam pendekatan preventif modern. Kombinasi atau pendekatan bertahap dari ketiga metode ini akan menjadi strategi terbaik untuk menekan angka kejadian kanker serviks, terutama bila didukung edukasi berkelanjutan dan kebijakan kesehatan publik yang inklusif. Dengan memahami karakteristik tiap metode, tenaga kesehatan dapat memberikan pelayanan deteksi dini yang tepat, aman, dan efektif kepada wanita usia subur di berbagai wilayah Indonesia.

Hambatan dalam Pelaksanaan Deteksi Dini

Pelaksanaan deteksi dini kanker serviks di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan yang bersifat multidimensional. Salah satu hambatan paling mendasar adalah rendahnya tingkat pengetahuan dan kesadaran wanita usia subur (WUS) tentang pentingnya skrining kanker serviks. Banyak perempuan belum memahami bahwa kanker serviks dapat dicegah melalui deteksi dini, atau mereka keliru menganggap pemeriksaan hanya perlu dilakukan jika ada gejala. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya edukasi kesehatan yang berkelanjutan berkontribusi besar terhadap rendahnya partisipasi dalam program skrining seperti IVA maupun Pap smear (Riyanti & Marpal, 2021).

Faktor budaya dan sosial juga memegang peran signifikan dalam menurunkan keikutsertaan WUS dalam skrining. Di banyak komunitas, pembicaraan mengenai organ reproduksi masih dianggap tabu, sehingga perempuan merasa malu

untuk menjalani pemeriksaan serviks, terutama jika ditangani oleh petugas kesehatan laki-laki. Selain itu, stigma bahwa kanker serviks terkait dengan perilaku seksual yang ‘menyimpang’ membuat sebagian WUS enggan memeriksakan diri karena takut dicap negatif. Rasa takut terhadap hasil diagnosis atau prosedur medis juga menjadi penghalang yang sering tidak diungkapkan secara langsung, namun terbukti memengaruhi keputusan perempuan untuk tidak melakukan deteksi dini (Suracmindari & Wulandari, 2021).

Dari sisi penyedia layanan, keterbatasan jumlah tenaga kesehatan terlatih menjadi hambatan serius, terutama di daerah pedesaan dan wilayah terpencil. Tidak semua puskesmas memiliki petugas yang terlatih secara khusus dalam melakukan skrining dengan metode IVA atau edukasi risiko kanker serviks. Bahkan jika tersedia, beban kerja yang tinggi serta keterbatasan waktu sering membuat edukasi dan pemeriksaan preventif menjadi prioritas rendah dalam pelayanan sehari-hari. Hal ini diperparah oleh kurangnya dukungan anggaran untuk penyediaan bahan dan alat skrining yang sesuai standar (Neliti, 2018).

Fasilitas kesehatan di beberapa daerah juga belum memiliki ruang atau sarana yang mendukung privasi dan kenyamanan pasien saat menjalani pemeriksaan. Misalnya, tidak adanya ruang khusus pemeriksaan yang tertutup atau tidak tersedia tempat tidur periksa yang memadai sering membuat WUS merasa tidak nyaman dan mengurungkan niatnya untuk melakukan skrining. Keadaan ini memperlihatkan pentingnya penyediaan fasilitas pelayanan yang ramah perempuan dan memperhatikan aspek kenyamanan serta martabat pasien dalam layanan deteksi dini.

Hambatan berikutnya adalah faktor ekonomi dan aksesibilitas. Bagi banyak WUS, terutama dari keluarga berpenghasilan rendah, prioritas utama adalah pemenuhan kebutuhan harian, bukan pemeriksaan kesehatan yang dirasa "tidak mendesak". Biaya transportasi ke puskesmas, kehilangan waktu kerja, atau ketakutan akan biaya lanjutan jika ditemukan kelainan, menjadi pertimbangan besar yang membuat mereka menunda atau menolak skrining. Hal ini umum ditemukan di wilayah dengan akses transportasi sulit atau distribusi fasilitas kesehatan yang tidak merata (Suracmindari & Wulandari, 2021).

Masalah sistemik lain yang tidak kalah penting adalah lemahnya sistem pencatatan, pelaporan, dan rujukan. Banyak hasil IVA test tidak tercatat secara sistematis, dan koordinasi dengan rumah sakit rujukan sering tidak berjalan lancar. Akibatnya, pasien dengan hasil positif tidak selalu mendapat tindak lanjut yang tepat waktu, sehingga tujuan dari deteksi dini menjadi tidak optimal. Tanpa sistem yang kuat untuk menjamin keberlanjutan dari skrining hingga pengobatan, pelaksanaan deteksi dini akan sulit memberikan dampak nyata terhadap penurunan angka morbiditas dan mortalitas akibat kanker serviks.

Strategi Mengatasi Hambatan Deteksi Dini

Untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan deteksi dini kanker serviks, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Salah satu strategi utama adalah peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya skrining kanker serviks. Kampanye informasi yang melibatkan media massa, tokoh masyarakat, dan organisasi keagamaan dapat membantu mengurangi stigma dan rasa malu yang seringkali menjadi penghalang bagi wanita usia subur (WUS) untuk melakukan pemeriksaan. Selain itu, pelatihan kader kesehatan di tingkat komunitas dapat memperluas jangkauan edukasi dan mendekatkan informasi kepada masyarakat (Suracmindari & Wulandari, 2021).

Pemerintah juga telah mengimplementasikan inovasi dalam metode skrining, seperti pengenalan metode self-sampling atau pengambilan sampel mandiri untuk tes HPV DNA. Metode ini memungkinkan perempuan untuk mengambil sampel sendiri di rumah, yang kemudian dikirim ke laboratorium untuk dianalisis. Pendekatan ini dapat mengatasi hambatan terkait rasa malu atau ketidaknyamanan saat diperiksa oleh tenaga kesehatan, serta meningkatkan partisipasi dalam program skrining (Antaranews, 2024). Selain itu, penggunaan teknologi seperti Gynpad, yang memungkinkan deteksi HPV melalui darah haid, juga menjadi alternatif yang menjanjikan dalam meningkatkan cakupan deteksi dini.

Penguatan sistem pelayanan kesehatan juga menjadi kunci dalam strategi ini. Peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan primer, seperti puskesmas, melalui pelatihan tenaga kesehatan dan penyediaan alat skrining yang memadai, dapat memastikan layanan deteksi dini tersedia secara merata. Selain itu, integrasi program deteksi dini dengan layanan kesehatan ibu dan anak dapat mempermudah akses bagi WUS. Pemerintah juga perlu memastikan adanya sistem rujukan yang efektif bagi pasien dengan hasil skrining positif untuk mendapatkan penanganan lanjutan yang tepat waktu (Kemenkes RI, 2023).

Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta juga penting dalam mendukung pelaksanaan strategi ini. Kemitraan dengan lembaga internasional, seperti WHO dan UNFPA, telah membantu dalam pengembangan kebijakan dan penyediaan sumber daya untuk program deteksi dini kanker serviks di Indonesia (WHO, 2024). Dengan pendekatan yang holistik dan kolaboratif, hambatan dalam pelaksanaan deteksi dini kanker serviks dapat diatasi, sehingga meningkatkan cakupan skrining dan menurunkan angka kematian akibat penyakit ini.

BAB 4

PERAN PERAWAT DALAM DETEKSI DINI KANKER SERVIKS

Peran Perawat sebagai Edukator

Perawat memiliki peran sentral sebagai edukator dalam upaya deteksi dini kanker serviks, terutama dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan wanita usia subur (WUS) mengenai pentingnya skrining. Sebagai tenaga kesehatan yang sering berinteraksi langsung dengan masyarakat, perawat dapat menyampaikan informasi yang akurat dan mudah dipahami tentang faktor risiko, gejala awal, serta manfaat dari pemeriksaan seperti Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA) dan Pap smear. Melalui pendekatan yang komunikatif dan empatik, perawat dapat membantu mengurangi rasa takut dan stigma yang seringkali menjadi penghalang bagi WUS untuk melakukan deteksi dini (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023).

Dalam konteks pelayanan kesehatan primer, perawat juga berperan dalam merancang dan melaksanakan program edukasi kesehatan yang terstruktur dan berkelanjutan. Program ini dapat mencakup penyuluhan di posyandu, kelas ibu hamil, serta kunjungan rumah yang bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan dan mendorong perilaku preventif. Perawat dapat memanfaatkan berbagai media edukasi, seperti leaflet, poster, dan media sosial, untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam. Dengan demikian, perawat tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya deteksi dini kanker serviks (*World Health Organization, 2021*).

Selain itu, perawat juga berperan dalam membimbing dan melatih kader kesehatan serta anggota masyarakat lainnya untuk menjadi agen edukasi di komunitas mereka. Melalui pelatihan dan pendampingan, perawat dapat memperluas jangkauan edukasi dan memastikan bahwa informasi yang disampaikan konsisten dan berbasis bukti. Peran ini sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung dan memfasilitasi perilaku deteksi dini yang proaktif di kalangan WUS. Dengan memperkuat kapasitas komunitas, perawat berkontribusi pada upaya penurunan angka kejadian dan kematian akibat kanker serviks secara berkelanjutan (*International Council of Nurses, 2020*).

Peran Perawat sebagai Advokat Kesehatan

Dalam konteks deteksi dini kanker serviks, perawat tidak hanya berperan sebagai pelaksana layanan tetapi juga sebagai **advokat kesehatan**, yaitu pembela kepentingan pasien dalam mengakses informasi dan pelayanan yang adil, setara, dan bermutu. Perawat memiliki tanggung jawab etis dan profesional untuk memastikan bahwa setiap wanita usia subur (WUS) mendapatkan haknya untuk

memperoleh edukasi dan layanan deteksi dini secara layak, tanpa diskriminasi dan hambatan struktural. Sebagai advokat, perawat harus peka terhadap ketidaksetaraan akses yang dialami oleh kelompok rentan, seperti perempuan dengan status sosial rendah, tinggal di wilayah terpencil, atau mengalami kekerasan. Dengan mengadvokasi kebijakan yang berpihak pada hak kesehatan perempuan, perawat menjadi penggerak dalam mewujudkan keadilan kesehatan (ICN, 2020; Potter et al., 2023).

Perawat sebagai advokat juga perlu berperan aktif dalam memfasilitasi komunikasi antara pasien dan sistem pelayanan kesehatan. Misalnya, ketika seorang WUS merasa takut atau tidak yakin untuk menjalani pemeriksaan IVA atau Pap smear, perawat dapat menjembatani dialog antara pasien, keluarga, dan dokter, serta mendampingi pengambilan keputusan secara informatif dan berempati. Selain itu, perawat juga dapat berperan dalam mendorong perubahan di tingkat kebijakan lokal dengan menyuarakan kebutuhan komunitas kepada pengambil kebijakan, seperti kepala puskesmas, dinas kesehatan, atau mitra swasta. Perawat yang menjalankan peran advokasi secara aktif akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan preventif dan mendorong partisipasi lebih tinggi dalam program deteksi dini kanker serviks (WHO, 2021).

Sebagai bagian dari profesi yang berbasis humanistik dan keadilan sosial, perawat juga harus mampu mengenali hambatan sistemik yang menghambat perempuan dalam mendapatkan layanan skrining, dan kemudian mendorong solusi. Ini termasuk memperjuangkan fasilitas yang ramah perempuan, menjamin adanya tenaga kesehatan perempuan untuk prosedur sensitif, serta mengadvokasi program deteksi dini berbasis komunitas yang lebih inklusif. Dalam konteks akademik dan pendidikan keperawatan, mahasiswa keperawatan

juga perlu ditanamkan nilai-nilai advokasi ini sejak dini agar mereka terbiasa menjadi pelindung hak-hak pasien di masa depan. Dengan menginternalisasi peran advokat kesehatan, perawat tidak hanya menjadi penyedia layanan, tetapi juga pelaku perubahan yang berkontribusi langsung pada pengurangan beban kanker serviks di Indonesia (Yuanita & Wahyuni, 2022).

Peran Perawat dalam Skrining Kanker Serviks

Perawat memegang peranan strategis dalam pelaksanaan skrining kanker serviks sebagai bagian dari upaya deteksi dini yang menyeluruh. Di tingkat layanan primer seperti puskesmas atau klinik, perawat sering menjadi tenaga kesehatan pertama yang melakukan komunikasi awal, edukasi, dan pelaksanaan skrining dengan metode Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA). Berdasarkan kebijakan Kementerian Kesehatan Indonesia, perawat yang telah mendapatkan pelatihan IVA berhak dan berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan pada wanita usia subur (WUS), terutama kelompok usia 30–50 tahun (Kementerian Kesehatan RI, 2023). Peran ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencakup kemampuan membangun hubungan terapeutik agar WUS merasa aman, percaya, dan bersedia menjalani prosedur pemeriksaan.

Selain melakukan skrining secara langsung, perawat juga berperan dalam mengidentifikasi WUS yang berisiko tinggi namun belum pernah melakukan deteksi dini. Ini meliputi pencatatan status reproduksi pasien, riwayat infeksi HPV, jumlah persalinan, dan informasi terkait gaya hidup seperti merokok atau status imunologis. Data ini menjadi dasar untuk menetapkan prioritas edukasi dan penjadwalan skrining sesuai kebutuhan masing-masing individu. Di lapangan, perawat juga dapat melakukan skrining berbasis komunitas dengan pendekatan jemput bola melalui kegiatan posyandu, kunjungan rumah, atau program kesehatan keluarga. Aktivitas ini menunjukkan bahwa peran skrining perawat

tidak terbatas di fasilitas, tetapi juga menjangkau ke ranah preventif komunitas (Yuanita & Dewi, 2022).

Perawat juga menjadi penghubung dalam sistem rujukan bila ditemukan hasil IVA positif atau adanya kecurigaan lesi pra-kanker. Dalam hal ini, perawat harus memahami alur rujukan yang cepat dan tepat, sekaligus memberikan pendampingan emosional kepada pasien. Keterampilan dalam dokumentasi, koordinasi, serta komunikasi antarfasilitas k

esehatan sangat penting untuk memastikan pasien tidak kehilangan waktu yang berharga. Perawat juga harus melakukan follow-up terhadap pasien yang telah dirujuk untuk memastikan keberlangsungan pengobatan. Dengan menjalankan fungsi ini secara optimal, perawat berperan langsung dalam menurunkan angka keterlambatan diagnosis dan menekan progresivitas kanker serviks di Indonesia (Bhatla et al., 2021; WHO, 2021).

Kompetensi Perawat dalam Deteksi Dini Kanker Serviks

Kompetensi perawat dalam deteksi dini kanker serviks mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional yang dibutuhkan untuk melaksanakan skrining dan edukasi kepada wanita usia subur (WUS). Seorang perawat harus memahami apa itu kanker serviks, bagaimana proses terjadinya, serta faktor risiko yang membuat perempuan rentan terhadap penyakit ini. Pengetahuan ini menjadi dasar agar perawat dapat menjelaskan kepada pasien dengan cara yang mudah dipahami dan meyakinkan. Selain itu, perawat juga harus tahu kapan waktu terbaik untuk melakukan skrining, siapa saja yang perlu diperiksa, dan apa saja tanda-tanda awal yang perlu diperhatikan (Potter et al., 2023).

Selain pengetahuan, keterampilan teknis sangat penting. Perawat harus mampu melakukan prosedur skrining seperti **IVA (Inspeksi Visual dengan Asam Asetat)** dengan benar dan aman. Ini termasuk cara mempersiapkan alat, posisi pasien yang tepat, penggunaan asam asetat, dan cara membaca hasilnya. Tidak hanya itu, perawat juga harus bisa mencatat hasil pemeriksaan dengan rapi, menyampaikan hasil secara sensitif, serta merujuk pasien ke fasilitas yang lebih lengkap jika ditemukan kelainan. Keterampilan ini hanya bisa dikuasai dengan pelatihan khusus dan praktik langsung di bawah supervisi tenaga profesional (Kementerian Kesehatan RI, 2023).

Kompetensi komunikasi juga tidak kalah penting. Perawat harus mampu menjelaskan kepada pasien tentang tujuan pemeriksaan, prosedurnya, dan apa yang akan dilakukan jika hasilnya positif. Penjelasan harus diberikan dengan bahasa yang sederhana, tidak menghakimi, dan menyesuaikan dengan latar belakang pendidikan pasien. Banyak perempuan merasa takut, malu, atau ragu karena belum pernah diperiksa sebelumnya. Di sinilah peran komunikasi perawat sangat penting dalam menciptakan rasa aman dan nyaman sehingga pasien mau menjalani pemeriksaan (ICN, 2020).

Sikap profesional adalah bagian dari kompetensi yang sering dianggap sepele, tetapi sangat penting dalam pelayanan deteksi dini. Perawat harus menjaga kerahasiaan hasil pemeriksaan, tidak membocorkan informasi pasien, dan memperlakukan semua pasien dengan hormat tanpa memandang latar belakang sosial atau budaya. Dalam konteks kanker serviks yang berkaitan dengan organ reproduksi, menjaga etika dan empati sangat diperlukan. Sikap terbuka, tidak menghakimi, serta mendukung pasien dalam setiap tahap pemeriksaan dan rujukan adalah bagian dari tanggung jawab perawat sebagai tenaga profesional (Yuanita & Wahyuni, 2022).

Agar semua kompetensi ini bisa tercapai, perawat perlu mengikuti pelatihan berkala yang diselenggarakan oleh institusi kesehatan atau organisasi profesi. Pemerintah juga mendorong perawat untuk mengikuti sertifikasi keterampilan IVA sebagai bentuk pengakuan kompetensi. Di lingkungan pendidikan, mahasiswa keperawatan juga perlu diberi pengalaman praktik skrining dan komunikasi kepada pasien secara langsung, agar mereka siap saat bekerja di lapangan. Dengan kompetensi yang baik, perawat akan lebih percaya diri, lebih efektif dalam edukasi, dan mampu membantu menurunkan angka kejadian kanker serviks melalui deteksi dini yang tepat (WHO, 2021).

BAB 5

MODEL PROMOSI KESEHATAN NOLA J. PENDER

Biografi Singkat Nola J. Pender



Gambar 5.1
Nola J. Pender

Nola J. Pender adalah seorang perawat dan akademisi asal Amerika Serikat yang dikenal luas karena kontribusinya dalam mengembangkan teori promosi kesehatan dalam keperawatan. Ia lahir pada tahun 1941 dan memulai karier keperawatannya dengan latar belakang pendidikan keperawatan di *Michigan State University*. Nola kemudian melanjutkan studi magister dan doktoralnya di bidang psikologi dan pendidikan keperawatan.

Pengalaman pendidikannya yang lintas disiplin ini membentuk cara pandanginya terhadap perilaku manusia dan bagaimana perawat dapat membantu klien mencapai kesehatan yang optimal. Semangatnya untuk mengedepankan pencegahan penyakit dan promosi kesehatan tercermin dalam karya-karyanya,

terutama dalam pengembangan *Health Promotion Model*(HPM). Hingga saat ini, tidak ada informasi yang menyatakan bahwa beliau telah meninggal dunia. Sebaliknya, beliau masih aktif sebagai Profesor Emerita di University of Michigan dan terus berkontribusi dalam bidang keperawatan melalui penelitian dan konsultasi di tingkat nasional maupun internasional. Dengan demikian, Nola J. Pender masih hidup dan tetap menjadi sosok yang berpengaruh dalam dunia keperawatan, khususnya dalam promosi kesehatan.

Sepanjang kariernya, Pender bekerja sebagai dosen dan peneliti di *University of Michigan* dan berkontribusi dalam banyak penelitian tentang perilaku kesehatan. Ia percaya bahwa perawat memiliki peran penting dalam membantu individu untuk mengubah gaya hidup mereka menjadi lebih sehat. Oleh karena itu, ia merancang model promosi kesehatan yang dapat digunakan perawat untuk memahami dan memengaruhi keputusan kesehatan pasien. Model ini telah digunakan di berbagai negara dan diterapkan dalam berbagai konteks keperawatan, termasuk keperawatan komunitas, maternitas, dan gerontologi. Sampai saat ini, model Nola J. Pender masih menjadi salah satu teori utama yang diajarkan dalam pendidikan keperawatan di seluruh dunia (Butts & Rich, 2021; Alligood, 2022).

Komponen Utama Model Promosi Kesehatan Pender

Model Promosi Kesehatan (*Health Promotion Model*/HPM) yang dikembangkan oleh Nola J. Pender terdiri dari tiga komponen utama: (1) karakteristik dan pengalaman individu, (2) keyakinan dan perasaan individu terhadap perilaku, dan (3) hasil atau perilaku promosi kesehatan yang diharapkan. Model ini bertujuan untuk membantu tenaga kesehatan, khususnya perawat, dalam memahami mengapa seseorang mau atau tidak mau melakukan tindakan yang bermanfaat bagi kesehatannya. Dalam konteks deteksi dini kanker serviks, model ini bisa

digunakan untuk menganalisis alasan wanita usia subur (WUS) memilih untuk melakukan atau menunda pemeriksaan IVA atau Pap smear. Perawat dapat menggunakan pemahaman ini untuk menyusun strategi edukasi dan pendekatan yang lebih efektif.

Komponen pertama, yaitu **karakteristik dan pengalaman individu**, mencakup faktor-faktor seperti usia, pengalaman sebelumnya terkait kesehatan, tingkat pendidikan, budaya, dan status sosial ekonomi. Misalnya, seorang perempuan yang pernah mengalami pelayanan skrining yang tidak nyaman mungkin enggan mengulangnya. Pengalaman masa lalu ini akan membentuk persepsi dan sikap mereka terhadap skrining berikutnya. Maka dari itu, perawat perlu mengevaluasi latar belakang pasien sebelum memberikan edukasi atau intervensi. Memahami latar belakang ini juga membantu perawat menyesuaikan bahasa, pendekatan, dan waktu yang tepat untuk mengajak pasien melakukan pemeriksaan (Alligood, 2022).

Komponen kedua adalah **keyakinan dan perasaan terhadap perilaku**, yang mencakup persepsi manfaat, hambatan, tingkat percaya diri (*self-efficacy*), dan pengaruh interpersonal seperti dukungan keluarga. Jika seorang WUS merasa bahwa skrining itu penting dan yakin bisa melakukannya tanpa rasa malu atau takut, maka dia lebih mungkin melakukannya. Di sisi lain, jika ia merasa tidak percaya diri, takut hasilnya, atau mendapat tekanan sosial untuk tidak memeriksakan diri, maka ia cenderung menolak. Komponen ketiga adalah **hasil atau perilaku kesehatan yang diinginkan**, yaitu perilaku aktual yang dilakukan individu sebagai hasil akhir dari pertimbangan dua komponen sebelumnya. Dalam hal ini, perilaku deteksi dini seperti melakukan IVA secara berkala adalah target yang ingin dicapai oleh perawat dalam praktik promosi kesehatan (Pender et al., 2019).

Implementasi Teori Pender dalam Keperawatan

Teori Promosi Kesehatan Nola J. Pender dapat diimplementasikan dalam praktik keperawatan sehari-hari, terutama dalam peran perawat sebagai pendidik dan motivator bagi pasien. Pender menekankan bahwa perawat perlu memahami kondisi unik setiap individu sebelum memberikan intervensi kesehatan. Ini berarti perawat harus mempertimbangkan latar belakang budaya, usia, pendidikan, dan pengalaman pasien sebelumnya saat menyampaikan edukasi atau mengajak mereka melakukan perilaku sehat. Dalam konteks deteksi dini kanker serviks, penerapan teori ini bisa dilihat saat perawat menyusun strategi komunikasi yang sesuai dengan karakteristik wanita usia subur (WUS), seperti menjelaskan manfaat IVA secara sederhana dan meyakinkan (Pender et al., 2019).

Salah satu cara nyata dalam mengimplementasikan teori ini adalah dengan **mengidentifikasi hambatan** yang dialami pasien, lalu mencari cara untuk mengurangnya. Misalnya, jika seorang WUS takut diperiksa karena merasa malu, perawat bisa menawarkan pemeriksaan oleh petugas perempuan dan memastikan ruangan yang privat. Jika pasien merasa tidak percaya diri, perawat bisa memberikan edukasi tambahan atau menunjukkan bahwa banyak perempuan lain juga melakukan skrining. Teori Pender menekankan pentingnya *self-efficacy* (rasa percaya diri pasien dalam mengambil keputusan dan bertindak), dan inilah yang perlu dibangun melalui pendekatan empatik dan suportif dari perawat (Alligood, 2022).

Selain itu, implementasi teori ini juga bisa dilakukan melalui **kerja sama lintas sektor** seperti melibatkan keluarga, tokoh masyarakat, atau organisasi keagamaan dalam kegiatan promosi kesehatan. Hal ini sesuai dengan poin dalam model Pender tentang **pengaruh interpersonal dan situasional**. Misalnya, jika perawat mengetahui bahwa seorang pasien lebih percaya pada tokoh agama

atau ketua RT, maka pendekatan edukatif bisa dilakukan bersama mereka agar pesan lebih diterima. Perawat yang menerapkan teori ini tidak hanya fokus pada penyakit, tetapi pada **upaya membentuk perilaku sehat** yang dipilih sendiri oleh pasien karena mereka merasa mampu, didukung, dan yakin bahwa tindakan itu membawa manfaat. Dengan begitu, implementasi teori Pender benar-benar menjadi alat bantu perawat untuk membuat promosi kesehatan yang lebih manusiawi dan efektif (Pender et al., 2019; Potter et al., 2023).

Model Pender dalam Konteks Deteksi Dini Kanker Serviks

Model Promosi Kesehatan yang dikembangkan oleh Nola J. Pender sangat relevan diterapkan dalam upaya deteksi dini kanker serviks, khususnya di kalangan wanita usia subur (WUS). Dalam konteks ini, model Pender membantu perawat untuk memahami mengapa sebagian perempuan mau melakukan skrining seperti IVA atau Pap smear, sementara yang lain enggan. Perawat dapat menganalisis faktor-faktor personal seperti pengalaman sebelumnya, tingkat pendidikan, status ekonomi, dan nilai budaya yang memengaruhi keputusan pasien. Dengan memahami latar belakang ini, perawat bisa memilih pendekatan edukasi yang lebih efektif dan membangun hubungan yang empatik. Tujuannya bukan hanya agar pasien mau skrining sekali, tapi agar mereka menyadari pentingnya pemeriksaan berkala sebagai gaya hidup sehat (Pender et al., 2019). Model Pender juga menekankan pentingnya persepsi pasien terhadap manfaat dan hambatan. Dalam praktik keperawatan, ini berarti perawat perlu menggali apa yang dirasakan pasien: apakah mereka percaya bahwa pemeriksaan skrining akan menyelamatkan hidup mereka, ataukah mereka justru takut dan merasa malu? Perawat dapat menggunakan komunikasi terbuka dan bahasa yang sederhana untuk membantu pasien membangun persepsi positif terhadap skrining. Selain itu, meningkatkan rasa percaya diri pasien (*self-efficacy*) menjadi bagian penting dari intervensi, misalnya, dengan menunjukkan bahwa banyak

perempuan lain juga berhasil melewati pemeriksaan tanpa masalah. Inilah kekuatan model Pender: membantu perawat merancang pendekatan promosi kesehatan yang menyentuh aspek psikologis dan sosial pasien (Alligood, 2022).

Komponen lain dalam model ini yang penting adalah dukungan lingkungan dan sosial. Dalam konteks deteksi dini kanker serviks, perawat bisa memanfaatkan pengaruh tokoh masyarakat, keluarga, atau komunitas untuk mendukung keputusan pasien menjalani skrining. Misalnya, jika seorang ibu merasa malu datang sendiri ke puskesmas, perawat bisa menyarankan agar ia datang bersama kelompok pengajian atau komunitas dasawisma. Dukungan seperti ini dapat memperkuat keputusan sehat dan memperluas jangkauan promosi kesehatan ke tingkat komunitas. Dengan kata lain, penerapan model Pender tidak hanya terjadi dalam ruang praktik klinis, tetapi juga dalam hubungan sosial yang mendukung perubahan perilaku menuju pencegahan kanker serviks (Potter et al., 2023; WHO, 2021).

BAB 6

MENGENAL STRATEGI “DEDIKASI”

Filosofi dan Makna DEDIKASI

Strategi DEDIKASI adalah singkatan dari *Deteksi Dini Kanker Serviks*, yang merupakan pendekatan intervensi berbasis edukasi dan konseling. Strategi ini bertujuan mendorong perempuan agar lebih proaktif dalam melakukan deteksi dini kanker serviks melalui **dorongan eksternal**, seperti media edukatif, keterlibatan kader, dan penyampaian informasi yang mudah diakses. DEDIKASI tidak hanya menawarkan metode edukasi, tetapi juga memfasilitasi proses perubahan perilaku melalui pendekatan yang ringan, relevan, dan membumi. Dengan menggunakan media seperti **e-booklet**, strategi ini membantu perempuan mengakses informasi yang sebelumnya terasa tabu atau sulit dijangkau. Tujuan akhirnya adalah memunculkan dorongan dari dalam diri perempuan (*internal motivation*) agar melakukan tindakan preventif tanpa harus menunggu gejala muncul.

Makna dari kata “DEDIKASI” sendiri merupakan akronim yang mencerminkan delapan langkah penting yang dibangun secara sistematis:

D	Deteksi
E	Edukasi
D	Dukung
I	Informasi
K	Konseling
A	Akses
S	Skrining
I	Inisiatif

Setiap huruf dalam DEDIKASI mewakili elemen penting dari proses promosi kesehatan yang dilakukan oleh perawat. Deteksi dan skrining adalah titik awal, sementara edukasi, informasi, dan konseling merupakan proses penguatan. Dukung dan akses menggambarkan peran lingkungan dan sistem pelayanan, sedangkan inisiatif menjadi simbol motivasi dari dalam diri perempuan itu sendiri. Ini menjadikan DEDIKASI bukan sekadar nama, melainkan **kerangka kerja yang menyatu dengan nilai-nilai keperawatan dan pemberdayaan komunitas**.

Lebih jauh, DEDIKASI dapat dipahami sebagai aplikasi nyata dari *Health Promotion Model* (HPM) Nola J. Pender yang telah dibahas dalam bab sebelumnya. Dalam model tersebut, perubahan perilaku kesehatan tidak terjadi secara instan, tetapi melalui proses membentuk persepsi manfaat, menurunkan hambatan, membangun kepercayaan diri (*self-efficacy*), dan memanfaatkan dukungan sosial. Semua aspek ini dihadirkan dalam DEDIKASI melalui pendekatan yang sistematis dan sensitif terhadap konteks lokal. Strategi ini juga memperkuat peran perawat sebagai **edukator, advokat, fasilitator, dan penggerak komunitas** sebagaimana diuraikan dalam Bab 4. Oleh karena itu, DEDIKASI bukan hanya strategi promosi, tetapi juga **cerminan filosofi keperawatan** yang holistik dan berbasis empati.

Prinsip Kerja dan Tujuan Strategi DEDIKASI

Strategi DEDIKASI bekerja berdasarkan prinsip edukasi berbasis komunitas dan pemberdayaan perempuan untuk melakukan deteksi dini kanker serviks secara mandiri dan sadar. Metode ini menggabungkan edukasi dan konseling yang disampaikan melalui media e-booklet singkat, kemudian didiskusikan secara kelompok agar lebih interaktif. Seluruh materi disusun sederhana, kontekstual, dan tidak menghakimi, agar mudah diterima oleh perempuan dengan latar belakang pendidikan yang beragam. Kegiatan dilakukan secara berkelompok, disertai *pre-post test* untuk mengukur perubahan pengetahuan dan sikap secara terukur.

Tujuan utama strategi ini adalah untuk meningkatkan literasi dan membentuk perilaku preventif pada wanita usia subur (WUS), khususnya dalam konteks pemeriksaan IVA. Strategi ini tidak hanya bertujuan menyampaikan informasi, tetapi juga mengurangi hambatan psikologis, membangun kepercayaan diri (*self-efficacy*), dan menciptakan dukungan sosial. Pendekatan ini memperkuat peran perawat sebagai fasilitator dan edukator yang menjembatani pengetahuan dengan praktik. Dengan prinsip kerja yang sederhana dan fleksibel, DEDIKASI dapat direplikasi di berbagai komunitas dengan dukungan tenaga kesehatan dan kader yang telah dilatih.

Komponen Utama DEDIKASI dalam e-Booklet

E-booklet DEDIKASI merupakan media utama dalam strategi promosi kesehatan ini. Isinya dirancang sederhana, bergambar, dan ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami oleh perempuan usia subur dari berbagai latar belakang pendidikan. Komponen dalam e-booklet disusun secara sistematis untuk memberikan pemahaman bertahap tentang kanker serviks dan pentingnya deteksi dini. Materi diawali dengan pengantar tentang anatomi sistem

reproduksi perempuan, diikuti dengan penjelasan tentang apa itu kanker serviks, bagaimana penularannya, siapa yang berisiko, serta gejala yang perlu diwaspadai. Penekanan utama adalah pada **pentingnya deteksi dini melalui IVA**, termasuk langkah-langkah melakukan pemeriksaan dan cara mengakses layanan.

Selain itu, e-booklet ini juga memuat bagian yang mengajak pembaca untuk mengenali faktor-faktor yang dapat menjadi penghalang dalam melakukan deteksi dini, seperti rasa takut, malu, atau kurang dukungan keluarga. Di bagian akhir, terdapat ajakan reflektif dan kutipan motivasi untuk memperkuat kepercayaan diri perempuan agar berani menjaga kesehatannya. Penyusunan konten dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip dalam Model Promosi Kesehatan Pender, yaitu memperkuat persepsi manfaat, mengurangi hambatan, dan membangun rasa percaya diri (*self-efficacy*). Oleh karena itu, e-booklet ini tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga bersifat persuasif dan membangun.

E-booklet DEDIKASI juga dilengkapi ilustrasi dan rangkuman poin penting di setiap halaman, sehingga memudahkan perawat atau kader saat digunakan dalam sesi edukasi kelompok. Materi ini dapat digunakan baik secara mandiri oleh perempuan maupun sebagai alat bantu oleh perawat saat memberikan edukasi. Dengan model ini, perawat dapat melibatkan pasien dalam proses belajar yang lebih partisipatif dan bermakna, sejalan dengan peran perawat sebagai edukator dalam Bab 4 dan prinsip pembentukan perilaku sehat dalam Bab 5. Keberadaan e-booklet ini membuktikan bahwa promosi kesehatan bisa dilakukan dengan alat yang sederhana, namun berdampak besar jika disampaikan dengan pendekatan yang tepat.

Alur Implementasi Strategi DEDIKASI

Pre-test dan post-test merupakan bagian penting dari implementasi strategi DEDIKASI yang bertujuan untuk menilai **efektivitas intervensi edukatif**. Pre-test dilakukan sebelum kegiatan edukasi dimulai, untuk mengukur tingkat pengetahuan awal, sikap, dan persepsi peserta tentang kanker serviks dan pentingnya deteksi dini. Sementara itu, post-test dilakukan setelah intervensi selesai, untuk mengetahui sejauh mana perubahan terjadi setelah peserta mendapatkan materi dari e-booklet dan diskusi kelompok.

Instrumen yang digunakan adalah **kuesioner terstruktur** yang disusun berdasarkan indikator literasi kesehatan, mencakup topik-topik seperti:

- Apa itu kanker serviks
- Siapa yang berisiko
- Tanda dan gejala yang perlu diwaspadai
- Tujuan dan manfaat pemeriksaan IVA
- Persepsi terhadap hambatan dan dukungan melakukan deteksi dini

Kuesioner ini sebaiknya disusun dalam bentuk **pilihan ganda atau benar-salah** dengan bahasa yang sederhana, agar mudah dipahami oleh peserta dari berbagai latar belakang pendidikan. Penilaian dilakukan secara individual, namun hasilnya dapat digunakan untuk **analisis kelompok**, sebagai bahan refleksi bagi fasilitator, dan dasar untuk perbaikan pelaksanaan ke depan.

Dengan demikian, *pre-post test* bukan hanya alat ukur, tetapi juga bagian dari proses pembelajaran dua arah antara perawat dan komunitas.

1. Kuesioner Pengetahuan tentang Kanker Serviks

Berisi 13 pertanyaan pilihan **ya/tidak**.

Penilaian:

- Jawaban benar: skor 2
- Jawaban salah: skor 1

Contoh item:

1. Kanker serviks adalah kanker yang menyerang leher rahim perempuan. (Ya/Tidak)
2. Salah satu penyebab kanker serviks adalah infeksi virus HPV. (Ya/Tidak)
3. Pemeriksaan IVA tidak bisa mendeteksi kanker serviks. (Ya/Tidak)
4. Perempuan yang sudah menikah saja yang berisiko terkena kanker serviks. (Ya/Tidak)
5. Pemeriksaan IVA hanya boleh dilakukan jika sudah mengalami gejala. (Ya/Tidak)
6. Pemeriksaan IVA dapat dilakukan di puskesmas secara gratis. (Ya/Tidak)
7. Kanker serviks bisa dicegah dengan deteksi dini. (Ya/Tidak)

Skor maksimal = $13 \times 2 = 26$

Skor minimal = $13 \times 1 = 13$

Kategori Interpretasi Skor Pengetahuan:

Skor Total	Kategori
13-17	Pengetahuan Rendah
18-22	Pengetahuan Sedang
23-26	Pengetahuan Tinggi

2. Kuesioner Sikap terhadap Deteksi Dini

Berisi 9 pernyataan dengan pilihan **ya/tidak**, untuk mengukur sikap dan kesiapan perilaku.

Contoh item:

1. Saya merasa deteksi dini kanker serviks penting untuk perempuan. (Ya/Tidak)

2. Saya bersedia melakukan pemeriksaan IVA jika mendapat informasi yang jelas. (Ya/Tidak)
3. Saya malu jika harus melakukan pemeriksaan IVA. (Ya/Tidak)
4. Saya khawatir jika hasil pemeriksaan menunjukkan ada kelainan. (Ya/Tidak)
5. Saya akan mengajak teman atau saudara perempuan untuk melakukan pemeriksaan IVA. (Ya/Tidak)

Bentuk soal: 9 pernyataan pilihan **Ya/Tidak**

Skoring: sesuai konteks pernyataan:

- Pernyataan positif → "Ya" = skor 2, "Tidak" = skor 1
- Pernyataan negatif (seperti malu, takut) → **dibalik**: "Tidak" = skor 2, "Ya" = skor 1

Skor maksimal = $9 \times 2 = 18$

Skor minimal = $9 \times 1 = 9$

Kategori Interpretasi Skor Sikap:

Skor Total	Kategori
9–12	Sikap Kurang Mendukung
13–15	Sikap Cukup Mendukung
16–18	Sikap Mendukung

Instrumen kuesioner yang digunakan dalam strategi DEDIKASI disusun berdasarkan indikator literasi kesehatan dan telah melalui proses validasi dalam penelitian sebelumnya. Kuesioner ini pertama kali dikembangkan dan diuji oleh **Rafika Rosyda (2018)**, yang membuktikan bahwa alat ukur ini memiliki reliabilitas yang baik. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa **kuesioner pengetahuan** memiliki nilai **Alpha Cronbach sebesar 0,737**, sedangkan **kuesioner sikap** memiliki nilai **Alpha Cronbach sebesar 0,775**. Nilai ini menunjukkan bahwa kedua instrumen tersebut reliabel dan layak digunakan untuk mengukur perubahan pengetahuan dan sikap peserta dalam intervensi edukatif mengenai deteksi dini kanker serviks.

Strategi DEDIKASI dirancang tidak hanya sebagai gagasan edukatif, tetapi sebagai langkah nyata yang dapat diterapkan langsung oleh perawat dan kader di lapangan. Untuk memastikan konsistensi pelaksanaan, berikut disusun alur implementasi DEDIKASI yang telah teruji dalam konteks edukasi deteksi dini kanker serviks pada wanita usia subur. Tabel ini memuat tahapan kegiatan, peran pelaksana, serta prinsip-prinsip yang mendasari strategi. Dengan mengikuti panduan ini, diharapkan intervensi DEDIKASI dapat dilakukan secara sistematis, efisien, dan tepat sasaran, baik di komunitas perkotaan maupun pedesaan.

Tahapan	Kegiatan	Keterangan
1. Persiapan	Menentukan lokasi pelaksanaan- Membentuk kelompok intervensi & kontrol	Lokasi bisa berupa posyandu, rumah kader, ruang komunitas. Kelompok disusun secara seimbang.
	Menyiapkan instrumen pre/post-test	Kuesioner tentang pengetahuan kanker serviks dan deteksi dini
	Menyediakan e-booklet cetak	Media utama intervensi edukatif
	Pelatihan perawat/kader	Minimal briefing agar fasilitator memahami isi e-booklet dan alur diskusi
2. Pre-Test	Dilakukan pada semua peserta	Sebagai baseline pengukuran literasi sebelum intervensi dilakukan
3. Intervensi	Kelompok intervensi: pembagian dan penjelasan e-booklet	Diskusi interaktif, fasilitator menjelaskan materi, memberi ruang tanya jawab
	Kelompok kontrol: edukasi konvensional	Hanya menggunakan ceramah dan tanya jawab; tidak diberikan e-booklet pada tahap ini
	Durasi per sesi $\pm 20-30$ menit	Disesuaikan dengan jumlah peserta (ideal 5-8 orang/kelompok)
4. Post-Test	Diberikan kembali kepada kedua kelompok	Instrumen sama dengan pre-test untuk menilai perubahan pengetahuan dan sikap

5. Evaluasi & Etika	Kelompok kontrol juga diberi e-booklet	Untuk memastikan seluruh peserta mendapatkan manfaat edukasi yang sama
	Mencatat hasil dan refleksi implementasi	Digunakan untuk evaluasi program dan tindak lanjut
Prinsip Pendukung	Sederhana, partisipatif, aplikatif- Tidak membutuhkan alat teknologi	Bisa dijalankan di daerah terpencil dengan media cetak dan fasilitator terlatih

Melalui alur implementasi yang sederhana namun bermakna ini, perawat memiliki panduan operasional untuk menjalankan perannya sebagai promotor kesehatan reproduksi perempuan. Strategi ini menunjukkan bahwa edukasi yang kuat tidak selalu membutuhkan teknologi tinggi, tetapi memerlukan ketulusan, keterlibatan aktif, dan pendekatan yang sesuai konteks. Dengan menjadikan DEDIKASI sebagai bagian dari praktik keperawatan sehari-hari, diharapkan lebih banyak perempuan yang terdorong melakukan deteksi dini, sehingga beban kanker serviks dapat ditekan sejak dari level komunitas.

BAB 7

IMPLEMENTASI STRATEGI “DEDIKASI” BERBASIS E-BOOK

Pengembangan Media e-Booklet untuk Deteksi Dini

E-booklet DEDIKASI dikembangkan sebagai salah satu media utama dalam strategi edukatif deteksi dini kanker serviks, khususnya bagi perempuan usia subur. Media ini dirancang untuk memberikan informasi yang mudah dipahami, ringkas, dan menarik, sehingga dapat digunakan oleh perawat maupun kader kesehatan dalam berbagai konteks pelayanan. Pada tahap awal, e-booklet yang digunakan merupakan hasil rancangan awal yang masih terbatas dari sisi kedalaman konten, ilustrasi, dan pendekatan perilaku. Evaluasi terhadap versi awal menunjukkan perlunya penyempurnaan agar media ini lebih selaras dengan prinsip-prinsip promosi kesehatan berbasis teori dan kebutuhan pengguna.

Berdasarkan evaluasi tersebut, dilakukan pengembangan ulang e-booklet dengan mengacu pada *Health Promotion Model* (HPM) Nola J. Pender. Setiap halaman disusun untuk menyentuh elemen-elemen penting seperti persepsi manfaat, hambatan, rasa percaya diri (*self-efficacy*), dan pengaruh interpersonal. Desain e-booklet menekankan narasi yang bersifat reflektif, ajakan personal, serta informasi praktis yang dapat diterapkan langsung. Tidak hanya menjelaskan apa itu kanker serviks, tetapi juga membantu pembaca memahami apa yang harus dilakukan, mengapa itu penting, dan bagaimana mengatasi rasa takut atau malu yang sering menjadi hambatan.

Media e-booklet ini dikembangkan dalam format slide berbasis PowerPoint agar dapat dicetak sebagai booklet atau diproyeksikan dalam kegiatan edukasi kelompok. Setiap halaman dirancang dengan visual menarik, ilustrasi anatomi sederhana, poin-poin edukatif, dan pesan motivasional. Kontennya tidak hanya memuat informasi biomedis, tetapi juga mengajak pembaca untuk berpikir, bertanya, dan menuliskan niat atau refleksi pribadi. Dengan pendekatan ini, e-booklet DEDIKASI tidak sekadar menjadi bahan bacaan, tetapi berfungsi sebagai **alat intervensi perubahan perilaku yang terukur dan bermakna.**

Pengembangan media ini juga mempertimbangkan hasil evaluasi dari peserta intervensi sebelumnya, di mana sebagian besar merasa lebih tertarik dengan media bergambar dan bahasa yang akrab. Oleh karena itu, isi e-booklet disesuaikan dengan konteks budaya, bahasa lokal, dan keterbatasan akses teknologi. E-booklet ini juga fleksibel: dapat digunakan secara individual oleh pasien, maupun secara berkelompok dalam kegiatan posyandu, penyuluhan RT, atau edukasi di ruang tunggu puskesmas. Dengan desain yang inklusif dan konten yang berbasis bukti, e-booklet DEDIKASI menjadi elemen kunci dalam upaya promotif yang mudah diterapkan oleh perawat di berbagai lini layanan.

Isi dan Konten e-Booklet Strategi DEDIKASI

E-booklet dalam strategi DEDIKASI disusun secara sistematis agar dapat menjadi media edukasi yang **mudah dipahami, menarik, dan memotivasi**. Konten e-booklet disusun berdasarkan kebutuhan informasi perempuan usia subur (WUS) terkait kanker serviks, serta prinsip perubahan perilaku dalam Model Promosi Kesehatan Nola J. Pender. Setiap halaman (slide) e-booklet memuat tema spesifik dengan paduan **pengetahuan dasar, pesan motivasional, dan refleksi pribadi** agar pembaca tidak hanya menerima informasi pasif, tetapi juga terdorong untuk berpikir dan bertindak.

Konten e-booklet terdiri dari **14 bagian utama**, yaitu:

No.	Judul Slide	Deskripsi
1	Sampul dan Judul	Halaman pembuka berisi judul utama dan visual ramah untuk membangun kesan positif dan menarik minat baca.
2	Salam & Pengantar	Ucapan pembuka dari perawat kepada pembaca, mengajak mengenal tubuh sendiri sebagai bentuk cinta dan kepedulian terhadap diri.
3	Pengertian Kanker Serviks	Penjelasan sederhana mengenai apa itu kanker serviks, letaknya di leher rahim, dan fakta bahwa kanker ini bisa dicegah jika ditemukan sejak dini.
4	Penyebab dan Penularan	Menjelaskan bahwa infeksi virus HPV adalah penyebab utama, ditularkan melalui hubungan seksual, dan sering tanpa gejala.
5	Kelompok Berisiko	Menggambarkan siapa saja yang berisiko (menikah muda, gonta-ganti pasangan, kurang menjaga kebersihan), disertai pertanyaan reflektif.
6	Gejala Klinis	Memuat gejala-gejala seperti perdarahan abnormal, nyeri panggul, dan keputihan berbau. Ditekankan bahwa banyak kasus tidak bergejala.
7	Upaya Pencegahan	Menjelaskan tiga pilar pencegahan: vaksinasi HPV, pola hidup sehat, dan pemeriksaan IVA secara berkala.
8	Mengenal Pemeriksaan IVA	Penjelasan ringan tentang prosedur IVA: cepat, aman, gratis, dan bisa dilakukan di puskesmas. Ditujukan untuk menurunkan rasa takut dan ragu.
9	Alasan Melakukan Deteksi Dini	Menyampaikan manfaat deteksi dini: peluang sembuh lebih besar, rasa aman, dan kontrol atas kesehatan sendiri.

10	Cerita Nyata Inspiratif	Menyisipkan kisah nyata perempuan yang selamat dari kanker berkat deteksi dini, untuk menginspirasi dan menyentuh sisi emosional pembaca.
11	Makna Akronim DEDIKASI	Menjelaskan arti setiap huruf dalam DEDIKASI dan hubungannya dengan upaya pencegahan dan promosi kesehatan berbasis peran perawat dan masyarakat.
12	Ajakan Aksi	Slide ini memberi ajakan konkret: cari tahu jadwal IVA, ajak teman, dan jangan tunda lagi. Disampaikan dalam kalimat positif dan persuasif.
13	Refleksi & Checklist	Halaman reflektif dengan kotak centang sederhana dan kolom "Saya akan periksa pada..." untuk mendorong komitmen pribadi.
14	Ucapan Terima Kasih & Kontak	Penutup yang mengapresiasi pembaca dan menyertakan info kontak faskes atau kader, agar pembaca tahu harus ke mana setelah membaca.

Setiap bagian ditulis dengan **bahasa non-medis yang komunikatif**, menggunakan kalimat pendek, dan dipadukan dengan ilustrasi. Materi tidak hanya mengedukasi, tetapi juga **membentuk sikap positif dan memperkuat motivasi internal** melalui pertanyaan reflektif, kutipan penguat, dan tampilan visual yang bersahabat. Hal ini sejalan dengan pendekatan edukasi berbasis empati dan personalisasi yang didukung dalam teori Nola Pender (Pender et al., 2019).

Dengan konten yang disusun seperti ini, e-booklet DEDIKASI tidak hanya memenuhi fungsi informasi, tetapi juga bertindak sebagai alat pendamping intervensi yang **mendorong perubahan perilaku sehat yang berkelanjutan**. Perawat, mahasiswa keperawatan, maupun kader kesehatan dapat menggunakan e-booklet ini sebagai sarana komunikasi yang sensitif terhadap konteks lokal dan kondisi psikososial perempuan usia subur.

Langkah-langkah Penggunaan e-Booklet dalam Praktik

Keperawatan

Penggunaan e-booklet dalam strategi DEDIKASI dilakukan melalui tahapan yang sistematis dan dapat direplikasi oleh tenaga kesehatan di berbagai tingkat layanan. Implementasi ini tidak hanya mencakup pemberian materi edukasi, tetapi juga melibatkan proses identifikasi peserta, pengukuran awal (pre-test), fasilitasi diskusi, hingga evaluasi pasca intervensi (post-test). Pendekatan ini menekankan keterlibatan aktif perawat, kader kesehatan, serta dukungan komunitas agar proses edukasi lebih bermakna dan berdampak.

Langkah pertama adalah **identifikasi peserta** berdasarkan kriteria inklusi. Perawat bersama kader memperkenalkan diri kepada calon peserta dan menjelaskan tujuan kegiatan. Setelah memperoleh persetujuan, peserta dibagi menjadi dua kelompok: **kelompok intervensi** (menerima edukasi dengan e-booklet) dan **kelompok kontrol** (mendapat edukasi biasa tanpa e-booklet). Pembagian dilakukan untuk melihat dampak penggunaan media e-booklet secara terukur.

Sebelum edukasi dilakukan, peserta dari kedua kelompok diminta untuk mengisi **kuesioner pre-test**. Kuesioner ini terdiri dari data demografi, tingkat pengetahuan, dan sikap terhadap deteksi dini kanker serviks. Pada tahap ini, perawat juga memberi bantuan bila ada peserta yang mengalami kesulitan dalam memahami isi kuesioner.

Selanjutnya, kelompok intervensi mengikuti sesi edukasi dengan **menggunakan e-booklet**. Sesi ini mencakup pembagian booklet, penjelasan visual dan naratif oleh perawat, serta sesi diskusi atau tanya jawab. Proses ini berlangsung selama kurang lebih 30–45 menit, dan dilakukan secara kelompok kecil agar partisipasi

lebih aktif. Sementara itu, kelompok kontrol hanya mendapatkan penjelasan dengan metode ceramah dan diskusi biasa, tanpa media e-booklet.

Setelah satu minggu, perawat kembali ke lokasi dan memberikan **post-test** kepada seluruh peserta. Saat post-test berlangsung, peserta tidak diperkenankan membuka e-booklet agar hasil lebih objektif. Perawat mengumpulkan hasil dan mencatat perbedaan skor sebagai dasar evaluasi efektivitas penggunaan media. Sebagai bagian dari prinsip etika, setelah seluruh proses selesai, kelompok kontrol juga diberikan akses terhadap e-booklet agar mereka tetap memperoleh manfaat edukatif yang setara.

Dalam praktiknya, peran **kader kesehatan sangat penting** dalam membantu mengingatkan peserta untuk membaca e-booklet dan mendampingi proses diskusi. Selain itu, kegiatan ini juga dapat dilengkapi dengan reward simbolik (misalnya, makanan sehat atau souvenir edukatif) sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi warga.

Dengan alur ini, penggunaan e-booklet DEDIKASI tidak hanya menjadi media informasi, tetapi menjadi bagian dari **proses perubahan perilaku yang sistematis dan dapat diukur**, sesuai dengan teori promosi kesehatan dan peran perawat sebagai fasilitator edukasi komunitas.

Evaluasi Efektivitas Penggunaan e-Booklet

Evaluasi efektivitas penggunaan e-booklet dalam strategi DEDIKASI dilakukan dengan membandingkan hasil **pre-test dan post-test** dari peserta kelompok intervensi dan kontrol. Pendekatan ini bertujuan untuk menilai apakah penggunaan e-booklet berdampak signifikan dalam meningkatkan **pengetahuan** dan **sikap positif** terhadap deteksi dini kanker serviks pada perempuan usia

subur. Pengukuran dilakukan menggunakan instrumen yang telah diuji reliabilitasnya dan disusun berdasarkan indikator literasi kesehatan reproduksi.

Pada kelompok intervensi, peserta diberikan e-booklet dan terlibat dalam sesi edukasi interaktif yang dipandu oleh perawat. Setelah satu minggu, dilakukan post-test dengan kuesioner yang sama. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar peserta mengalami peningkatan skor, baik pada aspek pengetahuan maupun sikap. Hal ini mengindikasikan bahwa e-booklet bukan hanya media informasi pasif, tetapi juga mampu mempengaruhi cara pandang dan kesiapan perempuan untuk melakukan pemeriksaan IVA.

Sebaliknya, pada kelompok kontrol yang tidak menggunakan e-booklet, peningkatan skor terjadi tetapi dalam rentang yang lebih kecil. Perbedaan antara kedua kelompok ini menunjukkan bahwa penyampaian materi dengan bantuan e-booklet lebih efektif dalam membentuk pemahaman dan motivasi. Evaluasi ini juga memperkuat fungsi e-booklet sebagai media edukasi yang menjembatani antara informasi dan tindakan nyata, sesuai dengan teori promosi kesehatan Nola Pender (Pender et al., 2019).

Selain evaluasi kuantitatif, perawat juga dapat melakukan **refleksi kualitatif** melalui diskusi atau wawancara singkat. Beberapa peserta menyampaikan bahwa gambar, cerita inspiratif, dan bahasa yang digunakan dalam e-booklet membuat mereka merasa lebih dekat dan tidak takut untuk bertanya. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas media tidak hanya diukur dari angka, tetapi juga dari penerimaan psikologis dan sosial peserta terhadap materi yang disampaikan.

Dengan demikian, e-booklet DEDIKASI terbukti memiliki **efektivitas edukatif dan promotif** yang kuat, serta dapat diadopsi dalam praktik keperawatan komunitas, posyandu, maupun penyuluhan mandiri. Ke depan, media ini dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai alat bantu edukasi nasional untuk mendorong deteksi dini kanker serviks secara masif dan terintegrasi.

BAB 8

STUDI KASUS DAN SIMULASI PRAKTIK

Studi Kasus Implementasi Strategi DEDIKASI

Untuk membantu mahasiswa dan perawat memahami bagaimana strategi DEDIKASI diterapkan dalam praktik nyata, berikut disajikan sebuah studi kasus yang diambil dari kegiatan edukasi deteksi dini kanker serviks di komunitas. Kasus ini menggambarkan langkah-langkah implementasi strategi mulai dari identifikasi peserta, pemberian edukasi menggunakan e-booklet, hingga evaluasi perubahan pengetahuan dan sikap.

Latar Belakang Kasus

Kegiatan edukasi dilakukan di sebuah Posyandu wilayah X, dengan target sasaran adalah **perempuan usia 30–50 tahun** yang belum pernah melakukan pemeriksaan IVA. Total peserta yang hadir adalah 20 orang, dibagi menjadi dua kelompok:

- **Kelompok Intervensi** (10 orang) → diberikan edukasi menggunakan e-booklet DEDIKASI
- **Kelompok Kontrol** (10 orang) → diberikan edukasi biasa melalui ceramah

Langkah-langkah yang Dilakukan

1. **Pre-test** diberikan kepada semua peserta untuk mengukur tingkat pengetahuan awal tentang kanker serviks dan deteksi dini.
2. **Edukasi Kelompok Intervensi:**
 - Peserta menerima e-booklet.
 - Perawat menjelaskan isi e-booklet secara langsung.
 - Diadakan diskusi dan sesi tanya jawab terbuka.
3. **Edukasi Kelompok Kontrol:**
 - Disampaikan melalui ceramah tanpa media visual atau booklet.
 - Durasi dan topik sama, hanya berbeda pada metode penyampaian.
4. **Post-test** dilakukan satu minggu setelah edukasi.
5. **Data pre-post test dibandingkan** untuk melihat peningkatan skor.

Hasil Singkat

- **Kelompok Intervensi** mengalami peningkatan pengetahuan dan sikap yang lebih signifikan dibanding kelompok kontrol.
- Beberapa peserta bahkan menyampaikan niat langsung untuk datang ke puskesmas melakukan IVA.
- Peserta menyebut booklet membantu mereka memahami karena berisi gambar, bahasa ringan, dan bisa dibaca ulang.

Makna Studi Kasus

Studi kasus ini menunjukkan bahwa **media edukasi sederhana seperti e-booklet** yang disampaikan dengan **pendekatan ramah dan interaktif** mampu meningkatkan kesadaran dan kesiapan perempuan untuk melakukan deteksi dini kanker serviks.

Bagi mahasiswa dan perawat, studi ini memperlihatkan bagaimana teori promosi kesehatan (Bab 5) dan peran perawat (Bab 4) diterapkan secara nyata dan mudah dalam setting komunitas.

Simulasi Praktik Deteksi Dini Kanker Serviks dengan Strategi DEDIKASI

Simulasi praktik merupakan bagian penting dalam pembelajaran karena memungkinkan mahasiswa dan perawat mengalami langsung bagaimana strategi DEDIKASI diterapkan di lapangan. Simulasi ini membantu peserta belajar cara menyampaikan edukasi, menggunakan e-booklet, dan berinteraksi dengan perempuan usia subur (WUS) secara komunikatif dan empatik.

Tujuan Simulasi

- Melatih kemampuan komunikasi edukatif berbasis e-booklet
- Mengembangkan peran perawat sebagai edukator dan fasilitator komunitas
- Meningkatkan pemahaman tentang langkah-langkah deteksi dini kanker serviks
- Mempersiapkan mahasiswa dan perawat menghadapi praktik nyata di masyarakat

Alur Simulasi

1. Pembagian Peran

- Mahasiswa dibagi dalam kelompok beranggotakan 3–5 orang.
- Peran dibagi menjadi: *Perawat edukator*, *Peserta WUS*, dan *Pengamat*.

2. Persiapan Simulasi

- Setiap kelompok diberi e-booklet DEDIKASI (versi cetak atau digital).

- Fasilitator memberi briefing singkat tentang alur edukasi dan waktu pelaksanaan (± 30 menit/sesi).
- 3. Pelaksanaan Simulasi**
- Perawat edukator menjelaskan isi e-booklet secara bertahap.
 - Peserta WUS diberi ruang bertanya, menunjukkan sikap ragu atau butuh penguatan (berbasis skenario).
 - Interaksi berlangsung secara interaktif, hangat, dan mengalir seperti di komunitas.
- 4. Refleksi Langsung**
- Setelah simulasi, dilakukan tanya jawab:
 “Apa yang sulit?”, “Apa respons pasien?”, “Apa yang harus diperbaiki?”
 - Setiap peran diminta menyampaikan pengalaman dan observasi.
- 5. Rotasi Peran (Opsional)**
- Setiap mahasiswa mencoba peran yang berbeda agar mendapatkan perspektif lengkap (edukator, pasien, pengamat).

Kondisi Ideal Simulasi

- Ruangan yang tenang dan nyaman
- Tersedia e-booklet yang dicetak berwarna atau ditampilkan lewat layar
- Fasilitator mendampingi dan memberi umpan balik
- Waktu pelaksanaan 45–60 menit per sesi kelompok

Simulasi ini juga bisa dilakukan di luar kelas, seperti di posyandu atau kegiatan pengabdian masyarakat. Mahasiswa dapat menggunakan simulasi ini sebagai bagian dari praktik komunitas atau intervensi promosi kesehatan sederhana yang sesuai dengan peran keperawatan.

Evaluasi dan Pembelajaran dari Simulasi Strategi DEDIKASI

Evaluasi simulasi dalam pembelajaran strategi DEDIKASI bertujuan untuk melihat sejauh mana mahasiswa atau perawat memahami materi, mampu menyampaikan edukasi dengan benar, dan dapat berperan aktif dalam situasi edukasi komunitas. Evaluasi ini tidak hanya fokus pada isi yang disampaikan, tetapi juga mencakup cara penyampaian, respons peserta, serta kemampuan beradaptasi dengan situasi yang mungkin terjadi di lapangan.

Penilaian dilakukan terhadap beberapa aspek, antara lain:

- **Pemahaman materi:** apakah perawat mampu menjelaskan isi e-booklet dengan runtut dan benar.
- **Kemampuan komunikasi:** penggunaan bahasa yang sederhana, sikap empatik, dan pendekatan yang tidak menghakimi.
- **Keterlibatan peserta:** apakah peserta WUS (dalam simulasi) merasa nyaman, paham, dan tertarik mengikuti diskusi.
- **Kreativitas dan inisiatif:** misalnya dalam menyesuaikan situasi, memberi contoh konkret, atau menguatkan motivasi pasien.
- **Refleksi pasca simulasi:** apakah mahasiswa mampu menilai dirinya sendiri dan rekan kelompoknya dengan jujur dan membangun.

Evaluasi ini dapat dilakukan secara langsung oleh dosen/fasilitator menggunakan lembar observasi sederhana, serta melalui refleksi tertulis oleh peserta simulasi. Mahasiswa juga diajak untuk saling memberi umpan balik antar kelompok dengan cara yang sopan dan konstruktif.

Melalui simulasi dan studi kasus implementasi DEDIKASI, mahasiswa dan perawat belajar bahwa edukasi bukan hanya soal “menyampaikan informasi,” tetapi soal **menyentuh dan menggerakkan perilaku**. Edukasi akan efektif bila

disampaikan dengan empati, visual yang jelas, bahasa yang dimengerti, dan waktu yang cukup.

Beberapa pelajaran penting yang sering muncul dari simulasi antara lain:

- **Pasien tidak langsung percaya saat pertama kali diberi informasi.** Dibutuhkan pendekatan hangat dan pelan-pelan.
- **E-booklet sangat membantu sebagai alat bantu visual,** tetapi hanya efektif jika perawat juga menjelaskan dengan komunikasi yang baik.
- **Peran kader dan lingkungan sangat penting** dalam menguatkan pesan edukasi. Ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh perawat.
- **Mahasiswa merasa lebih percaya diri setelah melakukan simulasi,** karena mereka belajar mengatasi rasa canggung dan tahu bagaimana cara memulai percakapan.

Simulasi juga memberi ruang bagi mahasiswa untuk **menemukan kelemahan dan memperbaikinya**, seperti kurang percaya diri, terlalu banyak istilah medis, atau kurang memberi ruang untuk tanya jawab. Simulasi dan studi kasus strategi DEDIKASI memberikan pengalaman belajar yang nyata dan kontekstual. Dengan pendekatan ini, mahasiswa dan perawat tidak hanya belajar teori promosi kesehatan, tetapi juga **mengalami langsung bagaimana menerapkannya** di komunitas. Evaluasi dan refleksi yang menyertainya membantu membentuk kepercayaan diri, empati, dan keterampilan edukasi yang sangat dibutuhkan dalam praktik keperawatan komunitas.

BAB 9

TANTANGAN DAN SOLUSI DALAM IMPLEMENTASI STRATEGI “DEDIKASI”

Hambatan Umum dalam Implementasi di Lapangan

Meskipun strategi DEDIKASI dirancang dengan pendekatan sederhana dan berbasis komunitas, implementasinya di lapangan tetap menghadapi berbagai tantangan. Hambatan-hambatan ini bisa muncul dari peserta, tenaga kesehatan, sarana prasarana, hingga kondisi sosial budaya yang ada di masyarakat. Memahami hambatan ini penting agar tenaga kesehatan tidak mudah menyerah, tetapi justru mampu merancang pendekatan yang lebih relevan dan efektif.

1. Rendahnya Literasi Kesehatan Masyarakat

Banyak perempuan usia subur di Indonesia, terutama di daerah rural dan pesisir, belum memahami apa itu kanker serviks, bagaimana penularannya, dan kenapa deteksi dini penting. Mereka cenderung menganggap diri "sehat" karena tidak merasakan gejala, padahal kanker serviks sering berkembang tanpa keluhan di tahap awal.

2. Rasa Takut, Malu, dan Stigma Sosial

Beberapa perempuan enggan mengikuti pemeriksaan IVA karena takut hasilnya buruk, malu membuka bagian tubuh tertentu, atau khawatir dihakimi oleh lingkungan sekitar. Di banyak daerah, topik organ reproduksi masih dianggap tabu dan tidak pantas dibicarakan secara terbuka.

3. Kurangnya Ketersediaan dan Distribusi E-booklet

Meskipun e-booklet mudah disebar secara digital, tidak semua wilayah memiliki akses yang baik terhadap perangkat atau internet. Di sisi lain, versi cetak sering terbatas karena keterbatasan biaya dan dukungan logistik.

4. Peran Perawat dan Kader yang Belum Maksimal

Beberapa perawat di layanan primer belum terbiasa menggunakan media edukatif seperti e-booklet dalam sesi penyuluhan. Selain itu, tidak semua kader mendapatkan pelatihan tentang isi materi dan cara menyampaikannya secara menarik dan tidak menggurui.

6. Waktu dan Tempat Edukasi yang Kurang Strategis

Edukasi sering dilakukan saat ibu-ibu sedang sibuk dengan urusan rumah tangga, atau dalam sesi posyandu yang padat agenda. Akibatnya, peserta tidak fokus atau hanya mengikuti setengah sesi. Selain itu, tempat edukasi kadang tidak nyaman atau terlalu terbuka.

7. Kurangnya Dukungan Keluarga

Beberapa perempuan tidak mendapatkan izin dari suami atau keluarga untuk memeriksakan diri. Hal ini membuat pesan edukasi yang disampaikan menjadi mandek di tengah jalan, meskipun peserta sudah mulai paham dan berniat melakukan skrining.

8. Ketiadaan Evaluasi dan Tindak Lanjut

Banyak kegiatan edukasi hanya dilakukan satu kali tanpa evaluasi dampak atau upaya tindak lanjut. Akibatnya, perubahan pengetahuan tidak

terkonversi menjadi tindakan nyata, seperti pemeriksaan IVA atau ajakan pada orang lain.

Hambatan-hambatan ini adalah realita yang sering ditemukan oleh perawat dan mahasiswa keperawatan saat terjun langsung ke komunitas. Namun, tantangan ini bukan untuk dihindari justru menjadi peluang untuk mengasah kreativitas, komunikasi empatik, dan kolaborasi lintas profesi yang lebih kuat.

Solusi Praktis Menghadapi Tantangan Implementasi

Menghadapi berbagai hambatan dalam pelaksanaan strategi DEDIKASI di lapangan bukanlah hal yang mengejutkan, terutama jika melihat kondisi geografis, sosial budaya, serta distribusi tenaga kesehatan di Indonesia yang sangat beragam. Namun, justru dalam keragaman itulah solusi harus disesuaikan—tidak selalu dengan pendekatan besar dan struktural, tetapi lewat langkah-langkah praktis yang bisa dilakukan oleh perawat, mahasiswa keperawatan, atau kader kesehatan secara langsung dan bermakna.

Salah satu solusi paling mendasar adalah memastikan bahwa edukasi yang diberikan **benar-benar relevan dengan latar belakang peserta**. Di banyak wilayah, perempuan usia subur memiliki tingkat pendidikan formal yang rendah, sehingga pendekatan yang digunakan tidak bisa terlalu akademik atau bersifat satu arah. Perawat harus mampu menyampaikan informasi dengan **bahasa lokal**, menggunakan perumpamaan yang akrab, dan mendekati peserta secara personal—tidak menggurui, tetapi mengajak.

Selain itu, penggunaan **media sederhana seperti e-booklet** dapat menjadi jembatan yang sangat efektif, asalkan disampaikan dengan cara yang tepat. Tidak cukup hanya membagikan e-booklet, tetapi perawat perlu membacakan, menjelaskan, dan berdiskusi langsung dengan peserta. Dalam hal ini, **kader lokal** yang sudah dipercaya masyarakat bisa dilatih untuk menjadi fasilitator.

Keterlibatan mereka akan mempermudah penerimaan pesan, mengingat mereka memahami kebiasaan dan nilai-nilai masyarakat setempat (Kemenkes RI, 2023).

Mengatasi rasa takut dan malu dalam melakukan pemeriksaan juga bisa dihadapi dengan **pemberdayaan kelompok kecil**, seperti arisan ibu-ibu, kelas ibu hamil, atau pengajian. Dalam suasana yang santai dan akrab, peserta akan lebih terbuka dan saling menguatkan. Jika satu orang berani memeriksa, biasanya akan muncul efek domino yang positif. Oleh karena itu, menciptakan lingkungan yang suportif dan membangun kepercayaan menjadi kunci penting dalam menembus hambatan psikososial.

Solusi lainnya adalah dengan **mengatur waktu edukasi secara fleksibel** dan menyesuaikan dengan kegiatan masyarakat. Misalnya, edukasi bisa dilakukan saat menunggu giliran posyandu, setelah senam pagi, atau bahkan di sela kegiatan PKK. Ketika edukasi disisipkan ke dalam rutinitas, partisipasi cenderung meningkat karena tidak membebani peserta secara waktu dan logistik.

Dari sisi tenaga kesehatan, penting untuk mendorong pelatihan yang berkelanjutan mengenai **komunikasi kesehatan dan penggunaan media edukatif**. Mahasiswa keperawatan harus diberikan kesempatan untuk praktik simulasi (seperti pada Bab 8), sehingga mereka terbiasa menyampaikan materi dengan cara yang komunikatif dan partisipatif. Pendekatan ini bukan hanya efektif, tetapi juga memperkuat peran perawat sebagai edukator komunitas yang reflektif dan berdaya.

Terakhir, salah satu solusi paling kuat adalah membangun sistem **tindak lanjut dan evaluasi sederhana**. Setelah edukasi selesai, perawat atau kader bisa kembali

satu minggu kemudian untuk menanyakan perkembangan peserta: apakah mereka sudah memahami, sudah mulai bertanya ke keluarga, atau sudah mencari tahu lokasi pemeriksaan IVA. Evaluasi semacam ini, walaupun informal, akan membuat peserta merasa dihargai dan didampingi.

Dengan kombinasi pendekatan yang fleksibel, partisipatif, dan berbasis empati, tantangan-tantangan besar dalam implementasi DEDIKASI bisa dijawab dengan cara-cara kecil yang konsisten. Dan justru dari konsistensi inilah akan muncul perubahan besar dalam perilaku dan kesadaran kesehatan perempuan Indonesia.

Kolaborasi Antarprofesi dalam Mendukung Implementasi DEDIKASI

Implementasi strategi DEDIKASI tidak bisa dilakukan oleh perawat seorang diri. Keberhasilan program edukasi dan deteksi dini kanker serviks di masyarakat sangat bergantung pada adanya kolaborasi lintas profesi. Kolaborasi ini penting untuk memperluas jangkauan edukasi, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta memfasilitasi akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan. Dalam konteks komunitas di Indonesia, kerja sama antara perawat, bidan, dokter, kader kesehatan, penyuluh KB, dan tokoh masyarakat menjadi elemen yang tak terpisahkan.

Perawat berperan sebagai inisiator edukasi dan pelaksana strategi DEDIKASI, namun untuk mencapai hasil yang optimal, mereka perlu bekerja berdampingan dengan **bidan dan dokter di layanan primer**. Bidan, yang selama ini dekat dengan perempuan dalam siklus kehamilan dan persalinan, memiliki pengaruh besar untuk menyampaikan pesan pencegahan kanker serviks. Sementara itu, dokter

bisa dilibatkan dalam validasi klinis, penyediaan informasi tambahan, atau merujuk peserta ke layanan lanjutan bila ditemukan indikasi lebih serius.

Kader kesehatan dan tokoh masyarakat juga memiliki peran strategis. Mereka dapat menjadi “penghubung sosial” antara tenaga kesehatan dan warga. Dalam banyak kasus, kehadiran kader dapat membantu menurunkan rasa takut atau malu peserta, karena mereka sudah dipercaya di lingkungan tempat tinggalnya. Bahkan, dalam kelompok masyarakat dengan keterbatasan literasi, informasi yang disampaikan oleh kader sering kali dianggap lebih meyakinkan karena disampaikan dalam bahasa sehari-hari yang akrab. Selain itu, **kerja sama dengan penyuluh KB, guru PAUD, atau pengurus PKK** juga bisa membuka jalur baru untuk pelaksanaan edukasi. Misalnya, edukasi DEDIKASI bisa disisipkan dalam sesi kelas ibu balita, posyandu lansia, atau kegiatan PKK RW. Pendekatan ini memperluas titik kontak strategi DEDIKASI dengan masyarakat dan memperkuat prinsip integrasi dalam promosi kesehatan.

Kolaborasi antarprofesi juga membantu dalam mengatasi hambatan teknis, seperti keterbatasan alat peraga, tempat edukasi, atau pendanaan cetak e-booklet. Dalam beberapa wilayah, kolaborasi dengan instansi pendidikan keperawatan atau Dinas Kesehatan setempat juga dapat membuka akses terhadap pelatihan bagi tenaga kesehatan dan kader. Dengan pendekatan bersama, beban pelaksanaan tidak hanya ada di tangan perawat, tetapi dibagi sesuai kompetensi dan kekuatan masing-masing profesi.

Model kolaborasi ini sejalan dengan semangat interprofessional collaboration (IPC) yang kini menjadi pendekatan penting dalam layanan kesehatan primer. IPC menekankan pentingnya komunikasi terbuka, saling menghargai, dan tujuan bersama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat (WHO, 2021). Bagi

mahasiswa dan perawat pemula, belajar membangun kolaborasi sejak dini adalah bekal penting agar intervensi kesehatan seperti DEDIKASI dapat dilaksanakan dengan efektif dan berkelanjutan.

Strategi Optimalisasi dan Keberlanjutan Program

Program edukasi deteksi dini kanker serviks melalui strategi DEDIKASI memiliki potensi besar untuk memperkuat kesadaran perempuan usia subur terhadap pentingnya pemeriksaan rutin. Namun, agar program ini tidak berhenti di satu kegiatan saja, dibutuhkan strategi yang mendukung **optimalisasi dan keberlanjutan** di tingkat komunitas. Keberlanjutan bukan hanya soal pengulangan program, tetapi memastikan bahwa edukasi menjadi bagian dari pola hidup dan praktik kesehatan masyarakat yang terus berkembang. Langkah pertama dalam optimalisasi adalah dengan **menjadikan edukasi DEDIKASI sebagai agenda rutin di layanan primer**, seperti posyandu, kelas ibu, atau penyuluhan desa. Perawat dan bidan yang bertugas di puskesmas dapat menyisipkan materi dari e-booklet ke dalam kegiatan yang sudah berjalan. Dengan integrasi ini, DEDIKASI tidak perlu menunggu program besar atau dana khusus, tetapi tumbuh sebagai bagian dari pelayanan sehari-hari.

Selain itu, **pemberdayaan kader** sangat penting untuk memperluas jangkauan dan memperkuat keberlanjutan. Kader yang sudah memahami isi e-booklet dan alur edukasi dapat menjadi duta edukasi lokal yang menjangkau perempuan lain di lingkungannya. Untuk itu, pelatihan kader perlu dilakukan secara berkala agar mereka selalu siap menjadi penguat informasi yang akurat dan relevan. Strategi optimalisasi lainnya adalah melalui **digitalisasi e-booklet**. Di tengah meningkatnya penggunaan ponsel pintar di kalangan masyarakat, e-booklet versi digital (PDF atau media sosial edukatif) dapat memperluas jangkauan edukasi hingga ke daerah dengan akses terbatas terhadap layanan kesehatan

formal. Mahasiswa keperawatan juga dapat dilibatkan dalam pembuatan konten kreatif berbasis e-booklet, seperti video singkat, reels, atau infografik berbahasa lokal.

Untuk menjaga keberlanjutan jangka panjang, dibutuhkan juga **dukungan dari pemerintah daerah dan lembaga pendidikan**. Program DEDIKASI bisa diajukan sebagai bagian dari program inovasi kesehatan masyarakat di tingkat kelurahan atau kecamatan. Institusi pendidikan keperawatan juga dapat menjadikan DEDIKASI sebagai bagian dari kegiatan pengabdian masyarakat rutin, tugas praktik komunitas, atau seminar mahasiswa.

Akhirnya, monitoring dan evaluasi perlu dilakukan secara ringan namun konsisten. Perawat dan kader dapat mencatat jumlah peserta yang sudah mengikuti edukasi, yang menyatakan siap diperiksa, atau yang benar-benar datang ke fasilitas kesehatan. Data sederhana ini dapat membantu mengevaluasi sejauh mana pesan DEDIKASI tersampaikan dan ditindaklanjuti. Dengan dukungan kolaboratif dan pendekatan yang fleksibel, strategi DEDIKASI bukan hanya akan hidup dalam buku atau pelatihan, tetapi akan terus berdenyut di tengah masyarakat menghidupkan kesadaran, membentuk kebiasaan, dan mencegah kematian yang sebenarnya bisa dicegah.

Daftar Pustaka

- Alligood, M. R. (2022). *Nursing Theorists and Their Work* (10th ed.). Elsevier.
- American Cancer Society. (2023). *Cervical cancer causes, risk factors, and prevention*. <https://www.cancer.org/cancer/types/cervical-cancer/causes-risks-prevention.html>
- American Cancer Society. (2023). *Cervical cancer stages*. <https://www.cancer.org/cancer/cervical-cancer/detection-diagnosis-staging/staging.html>
- American Cancer Society. (2023). *Signs and symptoms of cervical cancer*. <https://www.cancer.org/cancer/cervical-cancer/detection-diagnosis-staging/signs-symptoms.html>
- Antaranews. (2024). *Sampel mandiri solusi tingkatkan minat deteksi dini kanker serviks*. <https://www.antaranews.com/berita/4498473/sampel-mandiri-solusi-tingkatkan-minat-deteksi-dini-kanker-serviks> Antara News
- Astuti, B. W. (2021). Pendidikan kesehatan reproduksi dan perawatan genital hygiene pada wanita usia subur. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(3). <https://doi.org/10.37287/jpm.v5i3.1862> Global Health Science Journal
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2020). *Laporan Tahunan BKKBN 2020*. <https://www.bkkbn.go.id>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2023*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/WVc0MGEyMXBkVFUxY25KeE9HdDZkbTQzWkVkb1p6MDkjMw%3D%3D/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin--2023.html?year=2023> Badan Pusat Statistik Indonesia+1sumbabaratdayakab.bps.go.id+1
- Bhatla, N., Aoki, D., Sharma, D. N., & Sankaranarayanan, R. (2019). Cancer of the cervix uteri: 2021 update. *International Journal of Gynecology and Obstetrics*, 155(S1), 28–44. <https://doi.org/10.1002/ijgo.13999>
- Bruni, L., Albero, G., Serrano, B., Mena, M., Gómez, D., Muñoz, J., Bosch, F. X., & de Sanjosé, S. (2019). Human Papillomavirus and related diseases report. *ICO/IARC Information Centre on HPV and Cancer (HPV Information Centre)*. <https://hpvcentre.net/statistics/reports/XWX.pdf>
- Bruni, L., Albero, G., Serrano, B., Mena, M., Gómez, D., Muñoz, J., Bosch, F. X., & de Sanjosé, S. (2019). *Human Papillomavirus and Related Diseases in the World: Summary Report 2019*. ICO/IARC HPV Information Centre. <https://hpvcentre.net/statistics/reports/XWX.pdf>
- Butts, J. B., & Rich, K. L. (2021). *Philosophies and Theories for Advanced Nursing Practice* (4th ed.). Jones & Bartlett Learning.

- Canadian Cancer Society. (2022). *Cervical cancer risks*. <https://cancer.ca/en/cancer-information/cancer-types/cervical/risks>
- Cancer Today. (2022). *Cervical Cancer: A Global Challenge*. <https://www.cancertodaymag.org/winter-2022-2023/cervical-cancer-a-global-challenge/>
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2021). Cervical cancer risk factors. https://www.cdc.gov/cancer/cervical/basic_info/risk_factors.htm
- Centers for Disease Control and Prevention. (2021). *Cervical Cancer Screening*. https://www.cdc.gov/cancer/cervical/basic_info/screening.htm
- Centers for Disease Control and Prevention. (2021). *What are the symptoms of cervical cancer?* https://www.cdc.gov/cancer/cervical/basic_info/symptoms.htm
- Diskominfo Bengkalis. (2025). *TP PKK Deteksi Dini Kanker Serviks Dengan Iva Test Gratis Bagi Masyarakat*. Diakses dari <https://diskominfoitik.bengkaliskab.go.id/web/detailberita/20015/tp-pkk-deteksi-dini-kanker-serviks-dengan-iva-test-gratis-bagi-masyarakat->
- FIGO Cancer Report. (2018). *Staging classification for cancer of the cervix uteri. International Journal of Gynecology & Obstetrics*, 143(S2), 22–36. <https://doi.org/10.1002/ijgo.12611>
- GLOBOCAN. (2020). *Cancer incidence and mortality Indonesia 2020*. International Agency for Research on Cancer, WHO. <https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/360-indonesia-factsheets.pdf>
- GLOBOCAN. (2020). *Cancer Today - Indonesia Fact Sheet*. International Agency for Research on Cancer. <https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/360-indonesia-fact-sheets.pdf>
- Institute for Health Metrics and Evaluation. (2019). *Global Burden of Disease Study 2019*. <https://www.healthdata.org>
- International Council of Nurses. (2020). *The Role of Nurses in Promoting Health Equity*. <https://www.icn.ch/system/files/documents/2020-07/ICN%20Health%20Equity%20Report%20EN.pdf>
- Jannah, N. F., & Hanum, S. M. F. (2025). Bekali wanita pencegahan kanker serviks. *Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*. <https://fikes.umsida.ac.id/bekali-wanita-pencegahan-kanker-serviks/>
- Jayanti, K., & Pujiati, P. (2023). Karakteristik wanita usia subur dalam pemilihan jenis kontrasepsi injeksi. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), 2065–2073. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i6.1005>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI). (2023). *Skrining Kanker Serviks Modal Utama Tanggulangi Kematian Perempuan*. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis->

- media/20240202/2144908/skrining-kanker-serviks-modal-utama-tanggulangi-kematian-perempuan/Sehat Negeriku
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2013). *Deteksi Dini Kanker Serviks Pada Wanita Usia Subur*. <https://www.ejournal-aipkema.or.id/index.php/jrki/article/downloadSuppFile/207/42>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). *Profil Kesehatan Indonesia 2018*. <https://www.kemkes.go.id>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Petunjuk Teknis Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dan Kanker Payudara di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer*. Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Posyandu dan Kesehatan Reproduksi di Komunitas*.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim Metode IVA di Puskesmas*. Jakarta: Direktorat P2PTM.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dan Payudara*. Jakarta: Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Profil Kesehatan Indonesia 2023*. Retrieved from <https://www.kemkes.go.id>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Skrining Kanker Serviks Modal Utama Tanggulangi Kematian Perempuan*. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20240202/2144908/skrining-kanker-serviks-modal-utama-tanggulangi-kematian-perempuan/>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). *Rencana Kanker Nasional 2024–2034*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Lammerink, E. A., de Bock, G. H., Pras, E., Reyners, A. K., Mourits, M. J., & Kamps, W. A. (2021). Sexual functioning of cervical cancer survivors: A review. *International Journal of Gynecological Cancer*, 31(5), 745–752. <https://doi.org/10.1136/ijgc-2020-002235>
- Lee, H. Y., et al. (2011). Overcoming Barriers to Cervical Cancer Screening Among Asian American Women. *Journal of Women's Health*, 20(10), 1471–1479. <https://doi.org/10.1089/jwh.2010.2345>
- Lestari, D., & Wahyuni, R. (2018). Tantangan dalam Implementasi Program Deteksi Dini Kanker Serviks dengan Metode IVA di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 14(2), 123–130. <https://www.neliti.com/publications/272170/tantangan-dalam-implementasi-program-deteksi-dini-kanker-serviks-dengan-metode-i>
- Medical Channel Asia. (2024). Is Asia losing the fight against cervical cancer? <https://medicalchannelasia.com/is-asia-losing-the-fight-against-cervical-cancer/>

- Mutammimah, F., Nurjanah, N., & Nurfita, N. R. (2023). Hubungan pengetahuan dan karakteristik wanita usia subur (WUS) terhadap perilaku deteksi dini kanker serviks. *Jurnal Rumpun Ilmu Kesehatan*, 3(2), 226–236. <https://doi.org/10.55606/jrik.v3i2.2406E-Jurnal Politeknik Pratama+1E-Jurnal Politeknik Pratama+1>
- Neliti. (2018). *Tantangan dalam Implementasi Program Deteksi Dini Kanker Serviks dengan Metode IVA*. <https://www.neliti.com/publications/272170/tantangan-dalam-implementasi-program-deteksi-dini-kanker-serviks-dengan-metode-i>
- Oktafah, S. N. A., Fajria, L., & Wahyu, W. (2023). *Perilaku Pencegahan Kanker Serviks pada Wanita Usia Subur*. Indramayu: Penerbit Adab.
- Pender, N. J., Murdaugh, C. L., & Parsons, M. A. (2019). *Health Promotion in Nursing Practice* (7th ed.). Pearson.
- Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P. A., & Hall, A. M. (2023). *Fundamentals of Nursing* (11th ed.). Elsevier.
- Rahmawati, M., & Wijaya, L. N. (2024). Efek program keluarga berencana terhadap wanita usia subur. *Jurnal Kesehatan Madani Medika*, 15(1), 116–123. <https://doi.org/10.36569/jmm.v15i01.374jurnalmadanimedika.ac.id>
- Riyanti, N., & Marpal, F. A. (2021). Hambatan Wanita Usia Subur (WUS) dalam Melakukan Deteksi Dini Kanker Serviks. *Jurnal Aisyiyah Medika*, 6(1), 1–10. <https://jurnal.stikes-aisyiyah-palembang.ac.id/index.php/JAM/article/view/1317>
- Rizk, D. E. E., et al. (2017). Male circumcision and its relationship to cervical cancer. *International Journal of Gynecology & Obstetrics*, 138(2), 237–241. <https://doi.org/10.1002/ijgo.12188>
- Rosyda, R. (2018). *Pengembangan Media Edukasi Deteksi Dini Kanker Serviks Berbasis Komunitas*. Jurnal Ilmiah Kebidanan.
- Sankaranarayanan, R., Nessa, A., Esmay, P. O., & Dangou, J. M. (2013). Visual inspection methods for cervical cancer prevention. *Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology*, 26(2), 221–232. <https://doi.org/10.1016/j.bpobgyn.2011.08.003>
- Suracmindari, S., & Wulandari, L. P. (2021). *Faktor Penyebab Rendahnya Capaian Deteksi Dini Kanker Leher Rahim Metode IVA pada WUS 30–50 Tahun di Wilayah Puskesmas Cisadea*. Jurnal Pendidikan Kesehatan, 10(1), 1–11. <https://ojs.poltekkes-malang.ac.id/index.php/jpk/article/download/2238/321/>
- Syalfina, I., Irawati, R., Priyanti, R., & Sulistyawati, S. (2022). Upaya peningkatan kualitas kesehatan reproduksi WUS melalui edukasi tentang keputihan. *Jurnal Bernas*, 2(1), 336–345. Ejournal Universitas Majalengka
- Tessema, G. A., Roba, H. S., Assefa, N., & Tesema, A. G. (2023). Early sexual debut and associated factors among young women in sub-Saharan Africa. *PLOS Global Public Health*, 3(1), e0000941. <https://doi.org/10.1371/journal.pgph.0000941>

- Triharini, M., Pratiwi, N. L., & Setyowati, D. (2022). Peran Tenaga Kesehatan dalam Edukasi Deteksi Dini Kanker Serviks di Komunitas. *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, 17(1), 53–60.
- UNFPA Indonesia. (2021). *Universal access to reproductive health services*. https://indonesia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Booklet_Universal_Access_to_Reproductive_Health.pdf UNFPA Indonesia
- United Nations Population Fund (UNFPA). (2022). *Sexual and reproductive health and rights: An essential element of universal health coverage*. <https://www.unfpa.org/publications>
- United Nations Population Fund (UNFPA). (2022). *State of World Population: Seeing the Unseen*. <https://www.unfpa.org/publications>
- Universitas Indonesia. (2023). *Tingginya Angka Kasus Serviks di Indonesia Akibat Screening Rendah*. Diakses dari <https://www.ui.ac.id/tingginya-angka-kasus-serviks-di-indonesia-akibat-screening-rendah/>
- Wigatia, A., Nisak, A. Z., & Astuti, D. (2023). Peran dukungan tenaga kesehatan yang mempengaruhi wanita dalam melakukan deteksi dini kanker serviks. *Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan*, 14(1), 55–61. <https://pdfs.semanticscholar.org/0b8a/ae601359af98502ccfa2ca715427084222fb.pdf>
- Wong, L. P., et al. (2021). Barriers to and Facilitators of Cervical Cancer Screening among Asian Women: A Systematic Review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(8), 3971. <https://doi.org/10.3390/ijerph18083971>
- World Health Organization (WHO). (2022). *Cervical cancer*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cervical-cancer>
- World Health Organization (WHO). (2022). *Cervical cancer*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cervical-cancer>
- World Health Organization (WHO). (2024). *WHO, UNFPA mengapresiasi upaya Indonesia mengeliminasi kanker serviks, mendorong strategi vaksin terpadu, dan memperkuat skrining*. <https://www.who.int/indonesia/id/news/detail/15-11-2024-who--unfpa-commend-indonesia-s-efforts-to-eliminate-cervical-cancer--urge-streamlined-vaccine-strategy-and-enhanced-screening>
- World Health Organization. (2016). *Sexually transmitted infections (STIs)*. [https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/sexually-transmitted-infections-\(stis\)](https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/sexually-transmitted-infections-(stis))
- World Health Organization. (2021). *WHO guideline for screening and treatment of cervical pre-cancer lesions for cervical cancer prevention*. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240030824>
- World Health Organization. (2025). *How Indonesia aims to rapidly improve reproductive, maternal, newborn, child and adolescent health*. <https://www.who.int/indonesia/news/detail/16-01-2025-new-year--new->

opportunities--how-indonesia-aims-to-rapidly-improve-reproductive--maternal--newborn--child-and-adolescent-healthWorld Health Organization

- Wuriningsih, A. Y., Nafisa, D. U., Wahyuni, S., Rahayu, T., & Distinarista, H. (2021). Dukungan petugas kesehatan memengaruhi pemeriksaan pap smear pada perempuan usia subur. *NURSCOPE: Jurnal Penelitian dan Pemikiran Ilmiah Keperawatan*, 7(2), 117–122. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jnm/article/download/20581/6684>
- Yuanita, Y. (2020). Karakteristik Wanita Usia Subur dengan Perilaku Pencegahan Kanker Serviks. *Jurnal Kesehatan*, 12(2), 260–268.
- Yuanita, Y., & Dewi, S. (2022). Peran Perawat dalam Pelaksanaan IVA Test sebagai Deteksi Dini Kanker Serviks. *Jurnal Keperawatan Reproduksi*, 8(2), 45–52. <https://doi.org/10.31290/jkr.v8i2.5231>
- Yuanita, Y., & Wahyuni, R. (2022). Penguatan Kompetensi Perawat dalam Skrining IVA di Pelayanan Primer. *Jurnal Keperawatan Reproduksi*, 8(1), 15–23. <https://doi.org/10.31290/jkr.v8i1.4568>
- Zhou, Y., Zhang, X., Lu, Q., Jin, Y., & Fang, Y. (2022). Psychological distress and quality of life in women with cervical cancer: A cross-sectional study. *BMC Women's Health*, 22(1), 1–9. <https://doi.org/10.1186/s12905-022-01656-6>

DEDIKASI: Strategi Inovatif Deteksi Dini Kanker Serviks pada Wanita Usia Subur

Buku ajar ini disusun sebagai panduan edukatif dan praktis bagi mahasiswa keperawatan, perawat, dan tenaga pendidik dalam memahami sekaligus mengimplementasikan strategi **DEDIKASI** (Deteksi Dini Kanker Serviks). Dengan pendekatan berbasis komunitas dan media e-booklet yang sederhana, strategi ini mendorong perubahan perilaku perempuan usia subur untuk lebih peduli terhadap kesehatan reproduksinya—khususnya melalui deteksi dini kanker serviks seperti pemeriksaan IVA.

Menggabungkan konsep *Health Promotion Model* (HPM) dari Nola J. Pender, buku ini tidak hanya menjelaskan aspek klinis kanker serviks dan karakteristik perempuan usia subur, tetapi juga membimbing pembaca dalam menyusun edukasi yang partisipatif, komunikatif, dan sesuai dengan konteks sosial masyarakat Indonesia.

Setiap bab dalam buku ini memuat materi terstruktur yang disusun mulai dari teori dasar, peran perawat sebagai edukator, penyusunan dan penggunaan e-booklet DEDIKASI, hingga simulasi praktik dan studi kasus nyata di lapangan. Di akhir buku, pembaca diajak untuk merefleksikan tantangan implementasi serta menyusun strategi keberlanjutan berbasis kolaborasi lintas profesi dan pemberdayaan komunitas.

Dengan bahasa yang mudah dipahami dan dilengkapi dengan contoh konkret, buku ajar ini menjadi rujukan penting bagi siapa pun yang terlibat dalam promosi kesehatan, khususnya dalam upaya pencegahan kanker serviks secara dini, efektif, dan berkelanjutan.

**DEDIKASI: Strategi Inovatif Deteksi Dini Kanker Serviks
pada Wanita Usia Subur**

Buku ajar ini disusun sebagai panduan edukatif dan praktis bagi mahasiswa keperawatan, perawat, dan tenaga pendidik dalam memahami sekaligus mengimplementasikan strategi DEDIKASI (Deteksi Dini Kanker Serviks). Dengan pendekatan berbasis komunitas dan media e-booklet yang sederhana, strategi ini mendorong perubahan perilaku perempuan usia subur untuk lebih peduli terhadap kesehatan reproduksinya khususnya melalui deteksi dini kanker serviks seperti pemeriksaan IVA.

Menggabungkan konsep Health Promotion Model (HPM) dari Nola J. Pender, buku ini tidak hanya menjelaskan aspek klinis kanker serviks dan karakteristik perempuan usia subur, tetapi juga membimbing pembaca dalam menyusun edukasi yang partisipatif, komunikatif, dan sesuai dengan konteks sosial masyarakat Indonesia.

Setiap bab dalam buku ini memuat materi terstruktur yang disusun mulai dari teori dasar, peran perawat sebagai edukator, penyusunan dan penggunaan e-booklet DEDIKASI, hingga simulasi praktik dan studi kasus nyata di lapangan. Di akhir buku, pembaca diajak untuk merefleksikan tantangan implementasi serta menyusun strategi keberlanjutan berbasis kolaborasi lintas profesi dan pemberdayaan komunitas.

Dengan bahasa yang mudah dipahami dan dilengkapi dengan contoh konkret, buku ajar ini menjadi rujukan penting bagi siapa pun yang terlibat dalam promosi kesehatan, khususnya dalam upaya pencegahan kanker serviks secara dini, efektif, dan berkelanjutan.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta



ISBN 978-623-10-9814-6



9

786231

098146